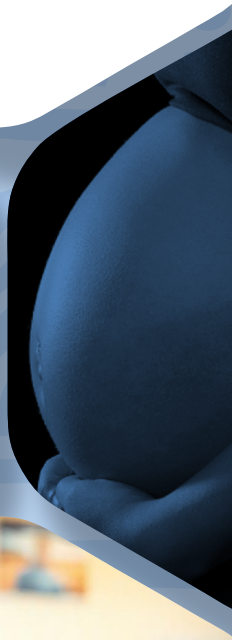


Pratiques Médicales et Expériences Entourant Les Naissances Intersexes Dans Les Hôpitaux Nigérians

Par Intersex Nigeria
(Centre Pour le Développement des Soins de Santé et L'autonomisation Des Jeunes)

Copyright©: Intersex Nigeria

Intersex Nigeria
(Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)

Informations de contact

Intersex Nigeria (Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)

Lagos and Abuja, Nigeria

info@intersexnigeria.org

+2349129057794

Visitez notre site web

www.intersexnigeria.org

Médias sociaux

@Intersex_nigeria_

@IntersexNigeria

@IntersexNigeria

Intersex Nigeria

Publiée: Intersex Nigeria
Droits d'auteur: Intersex Nigeria, 2024

Date de publication:
December, 2024

© Intersex Nigeria

Table des matières

I	**Table des matières**	**I**
II	**Avant-propos**	**II**
III.	**Remerciements**	**III**
IV.	**Résumé**	**IV**
1.0	**Introduction**	**01**
1.1	Contexte	01
1.2	Objectifs	02
2.0	**Comprendre l'intersexualité Perspectives biologiques et médicales**	04
2.1	Impacts psychologiques et sociaux des interventions médicales	04
2.2	Violations des droits de l'homme et protections juridiques	05
2.3	Système et pratiques de soins de santé	06
2.4	Revue de la littérature sur les études intersexes en Afrique	06
2.4.1	Prévalence de l'intervention chirurgicale/(IGM)	07
2.5	Aperçu des études sur l'intersexualité au Nigeria	08
3.0.	**Méthodologie**	**12**
3.1	Cartographie des hôpitaux et des praticiens médicaux	13
3.2	Collecte et analyse des données	13
4.0	**Constatations et discussion**	**16**
4.1	Démographie du répondant	16
4.2	Représentation régionale et spécialités	16
4.3	Sensibilisation et connaissance de l'intersexualité	18
4.4	Prévalence des naissances intersexuées	19
4.5	Évaluation et traitement cliniques des personnes intersexuées	20
4.6	Attitudes et pratiques des prestataires de soins de santé	26
4.7	Influences sociétales et culturelles sur le traitement de l'intersexualité	27
4.8	Discussion des résultats quantitatifs	27
4.9	Effets des interventions chirurgicales sur les personnes intersexuées	28
4.9.1.	Défis et considérations éthiques liés au traitement des personnes intersexuées.	29
4.9.2.	Expériences de l'intersexualité en termes de diagnostic et d'approche thérapeutique au Nigeria	30
4.9.3.	Impact des croyances culturelles et sociétales dans la gestion et le traitement de l'intersexualité au Nigeria	31
4.10	Effets des interventions chirurgicales sur les personnes intersexuées	32
5.0.	**Conclusion de l'étude**	**34**
5.1	Recommandation	34
	Références Annexes	**37**
	Liste des graphiques et tableaux	**38**
	Appendices	

Avant-propos

Le domaine de la science médicale est en constante évolution, mais certains domaines restent sousexplorés, souvent en raison des stigmates sociétaux, de l'intérêt des professionnels de la santé et de l'absence de priorité. Parmi ces domaines figure celui de l'intersexualité, un sujet qui mêle des dimensions biologiques, psychologiques et sociales complexes. Cette recherche vise à mettre en lumière ces complexités, en explorant la fréquence des naissances intersexuées, les pratiques médicales et les défis sociaux auxquels sont confrontées les personnes intersexuées. **La raison de cette étude découle d'un besoin pressant de combler les lacunes dans les connaissances et les incohérences dans la prise en charge des personnes intersexuées en milieu médical.** Malgré la prise de conscience croissante des problèmes liés à l'intersexualité dans le monde, il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans les régions **où les croyances culturelles et religieuses influencent considérablement les pratiques médicales et les attitudes sociétales.**

Grâce à la collecte et à l'analyse de données quantitatives et qualitatives, cette recherche examine la fréquence des naissances intersexuées, la prévalence des mutilations génitales intersexuées, les critères et méthodes de diagnostic utilisés par les professionnels de la santé, ainsi que les options thérapeutiques disponibles. Elle met également en évidence l'impact profond des interventions médicales, tant positives que négatives, sur l a vie des personnes intersexuées, ainsi que les implications sociétales plus larges.
Cette étude n'est pas un travail d'érudition, mais un appel à l'action. Elle exhorte les prestataires de soins de santé, les décideurs politiques et la société dans son ensemble à reconnaître les besoins uniques des personnes intersexuées et à plaider en faveur de pratiques médicales mieux informées, plus sensibles et plus éthiques. **Les résultats présentés ici constituent une étape vers la promotion d'une meilleure compréhension et d'un plus grand soutien aux personnes intersexuées, en veillant à ce que leurs droits et leur dignité soient respectés.**

Nous espérons que cette recherche constituera une ressource précieuse pour les professionnels de la santé, les universitaires, les défenseurs, les parties prenantes et les organismes donateurs qui s'engagent à faire progresser le bien-être et les droits des personnes intersexuées.

Que ce travail inspire un dialogue, une éducation et une réforme continus, pour aboutir à un monde où chaque personne, y compris les personnes intersexuées, est appréciée et respectée pour ce qu'elle est, indépendamment de ses différences biologiques innées.

Remerciements

Intrsex Nigeria (Center for Healthcare Development and Youth Empowerment) exprime sa profonde gratitude à tous les professionnels de la santé qui ont participé et contribué à cet important rapport de recherche. Votre ouverture d'esprit et vos perspectives ont été inestimables. Nous félicitons les consultants, le Dr Dauda Bathnna et Parton Titus, pour leur dévouement et leur engagement à faire aboutir ce travail.

Leur travail témoigne de la capacité de la recherche à susciter des changements sociaux et à améliorer les conditions de vie. Les enseignements tirés de cette étude contribueront sans aucun doute à une approche plus informée et plus empathique des personnes intersexuées, tant dans la pratique médicale que dans les attitudes sociétales.

Intersex Nigeria apprécie le soutien indéfectible du programme "Power of Pride", qui a permis de soutenir cette recherche et d'apporter de la visibilité aux questions intersexes au Nigeria. À toute l'équipe d'Intersex Nigeria, nous vous remercions pour votre engagement inébranlable à faire en sorte que ce projet soit mené à bien.

Résumé

Ce travail de recherche explore la sensibilisation, les connaissances et les pratiques cliniques concernant (le terme) intersexe parmi les professionnels de la santé au Nigeria. **Grâce à une enquête exhaustive menée auprès de personnes interrogées dans différentes régions du pays, l'étude se penche sur la fréquence des cas d'intersexualité, les interventions chirurgicales, les méthodes de diagnostic, les protocoles d'intervention médicale et les difficultés rencontrées par les personnes intersexuées à la suite d'interventions médicales.** L'objectif est de fournir une compréhension claire de l'état actuel des soins de santé pour les personnes intersexuées au Nigeria, en soulignant les lacunes dans les connaissances, la prévalence des interventions chirurgicales et le besoin de lignes directrices et de formations normalisées.

Les résultats révèlent que 85 % des professionnels de la santé ont rencontré au moins un cas d'intersexualité au cours des cinq dernières années, et qu'un grand nombre d'entre eux ont observé plusieurs cas. Cela souligne l'importance de développer des protocoles cliniques appropriés pour gérer efficacement ces personnes intersexuées. Le consentement au traitement a été majoritairement donné par les parents, ce qui met en évidence les considérations éthiques concernant la prise de décision pour les jeunes personnes intersexuées. La stigmatisation et le dysfonctionnement sexuel sont les problèmes les plus fréquemment signalés par les personnes intersexuées après le traitement, ce qui indique des impacts psychosociaux importants qui doivent être pris en compte dans les soins post-traitement.

Une recommandation essentielle consiste à élaborer des lignes directrices cohérentes et fondées sur des données probantes pour le diagnostic et la prise en charge de l'intersexualité dans tous les établissements de soins de santé.

Cette recherche est cruciale car elle met en lumière l'état actuel des soins de santé pour les personnes intersexuées au Nigeria, un sujet qui est souvent sous-étudié et mal compris. En identifiant les lacunes dans les connaissances, les incohérences dans les pratiques cliniques et les difficultés rencontrées par les personnes intersexuées, ce rapport jette les bases d'une amélioration des services de santé et des résultats pour ce groupe marginalisé.

Les recommandations formulées visent à favoriser un système de santé plus inclusif, en veillant à ce que les personnes intersexuées reçoivent les soins respectueux et compétents qu'elles méritent. Les intersexes étant de plus en plus reconnus dans les cadres médicaux et sociaux, les conclusions de cette étude sont essentielles pour orienter les politiques futures, les pratiques cliniques et les efforts de sensibilisation du public au Nigéria et au-delà.

1.0 Introduction

1.1. Contexte

Au Nigeria, les personnes intersexuées sont confrontées à des défis importants et à une discrimination systémique en raison des variations innées de leurs caractéristiques sexuelles (chromosomes, gonades, organes génitaux, hormones, etc.), qui ne sont pas conformes à la définition médicale et sociétale des corps masculins et féminins. Cette indifférence a conduit à l'application de pratiques d'intervention médicale et de documentation néfastes, au secret entourant les naissances intersexes, à l'invalidation des variations saines, à des interventions médicales non consenties et inutiles qui entraînent souvent de graves préjudices physiques, médicaux et psychologiques. En conséquence, les personnes intersexuées sont soumises à des niveaux élevés de déshumanisation, y compris l'isolement, les pratiques traditionnelles néfastes, la stigmatisation, l'assignation de sexe à tort, les attaques de la foule, l'infanticide et les interventions médicales inutiles (thérapie chirurgicale et hormonale).

Bien que les experts suggèrent qu'environ 0,05% à 1,7% de la population mondiale est née intersexuée (Esteban C. et.al (2023), il y a un manque important de données sur la population intersexuée au Nigéria.

Les naissances de bébés intersexués ne sont souvent pas enregistrées, et les rapports de violations telles que les mutilations génitales intersexes continues (MGI), l'humiliation publique due à l'apparence physique du sexe, et le harcèlement des personnes intersexuées ne sont pas documentés. Ce manque de données rend difficile la présentation de rapports complets, fondés sur des preuves, afin d'engager les institutions gouvernementales, les décideurs politiques et les personnes influentes dans des efforts de plaidoyer pour mettre fin à la MGI et aux autres violations des droits de l'homme à l'encontre des personnes intersexuées au Nigéria.

Il est nécessaire d'adopter une approche systématique pour documenter les naissances intersexuées et les interventions médicales sur les personnes intersexuées dans les hôpitaux nigérians. Cette recherche vise à combler ce manque de données en collectant et en analysant des données sur les naissances intersexuées et les pratiques médicales sur les personnes intersexuées dans les six zones géopolitiques du Nigéria. Ce faisant, nous visons à créer un outil de plaidoyer solide, basé sur des preuves, afin d'engager les parties prenantes concernées et de conduire des réformes politiques qui protègent les droits et le bien-être des personnes intersexuées.

1.2. Objectifs

Les principaux objectifs de cette recherche sont lessuivants

I. Élaborer un rapport complet sur le taux de naissances intersexuées dans au moins 50 hôpitaux tertiaires sélectionnés dans les six zones géopolitiques du Nigeria.

II. Documenter l'occurrence, la prévalence et les pratiques d'interventions chirurgicales non consensuelles (IGM) et d'autres interventions médicales sur les personnes intersexuées (bébés, enfants et adultes) au Nigeria.

III. Mettre en évidence les dangers et les effets négatifs de l'intervention chirurgicale non consensuelle (IGM) et d'autres interventions médicales sur les personnes intersexuées.

IV. Rassembler des informations et des faits adéquats pour étayer les efforts de sensibilisation visant à mettre fin à la MGI et à d'autres interventions médicales néfastes au Nigeria.

V. Fournir un rapport basé sur des preuves pour engager le gouvernement, les leaders communautaires, les prestataires de soins de santé et les influenceurs politiques à soutenir les processus de plaidoyer intersectionnel.

2.0. Comprendre l'intersexualité Perspectives biologiques et médicales

Les variations intersexes englobent une gamme de variations biologiques où la composition des caractéristiques sexuelles chromosomiques, gonadiques ou anatomiques d'un individu ne correspond pas à la définition médicale et sociétale des corps masculins et féminins. Selon Dreger (1998), ces variations comprennent le syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA), l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) et le syndrome de Klinefelter. Fausto-Sterling (2000) affirme que ces variations biologiques naturelles remettent en question la conception binaire du sexe, en soulignant la complexité et la diversité de la biologie humaine.

Historiquement, la littérature médicale a pathologisé les traits intersexuels, les considérant comme des troubles nécessitant une correction. Karkazis (2008) explique comment la communauté médicale a traditionnellement abordé l'intersexualité en mettant l'accent sur une intervention chirurgicale précoce visant à aligner l'apparence physique de l'individu sur les normes sociétales en matière de genre. Cette médicalisation ne tient souvent pas compte de la santé à long terme et du bien-être psychologique des personnes intersexuées, en donnant la priorité à l'aspect cosmétique. des résultats plutôt que des soins holistiques.

2.1. Impacts psychologiques et sociaux des interventions médicales

Des études ont montré les effets psychologiques négatifs des chirurgies génitales non consenties sur les personnes intersexuées. Tamar-Mattis (2013) a décrit le traumatisme à long terme, y compris la douleur chronique, la perte de la fonction sexuelle et une détresse psychologique importante, que de nombreuses personnes intersexuées subissent à la suite de ces interventions. Ce traumatisme est aggravé par un sentiment de trahison et un manque d'autonomie corporelle, car ces chirurgies sont souvent pratiquées pendant la petite enfance ou l'enfance sans le consentement de la personne.

La stigmatisation sociale et les luttes identitaires des personnes intersexuées sont bien documentées dans la littérature sociologique. Davis (2015) a mentionné comment les attentes sociétales et les binaires de genre rigides contribuent à la marginalisation et à la discrimination des personnes intersexuées. La stigmatisation s'étend aux familles, qui peuvent se sentir obligées de cacher ou de "réparer" les traits intersexuels de leur enfant pour éviter l'ostracisme social. Ces pressions peuvent conduire à des luttes identitaires importantes et à une stigmatisation intériorisée des personnes intersexuées, ce qui affecte leur santé mentale et leur intégration sociale.

2.2. Violations des droits de l'homme et protections juridiques

La reconnaissance juridique et la protection des droits des personnes intersexuées est une question cruciale. Carpenter (2016) affirme que l'absence de cadres juridiques spécifiques pour protéger les personnes intersexuées entraîne des violations généralisées des droits de l'homme, notamment des interventions médicales non consensuelles et des discriminations. Les organismes internationaux de défense des droits de l'homme, tels que les Nations unies, ont appelé à mettre fin à des pratiques telles que les mutilations génitales intersexes (MGI) et ont exhorté les pays à mettre en œuvre des politiques qui protègent l'autonomie corporelle et la dignité des personnes intersexes. La résolution 552 rappelle l'article 2 de la Charte qui interdit toute forme de discrimination. À cet égard, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir et protéger les droits des personnes, indépendamment de leur race, couleur, nationalité, citoyenneté, ethnie, profession, opinions politiques, sexe, caractéristiques sexuelles, orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre ou tout autre facteur susceptible d'entraîner une discrimination à leur égard. L'interprétation de l'article 2 de la Charte africaine est ouverte et inclusive, et vise à offrir une protection maximale à tous les Africains, d'où l'inclusion des caractéristiques sexuelles, du genre et de l'orientation sexuelle comme motifs interdits de discrimination.

la discrimination. Par conséquent, les États doivent interdire la discrimination fondée sur les traits, les caractéristiques ou le statut des personnes intersexuées dans tous les domaines de la vie et dans toutes les institutions sociales, y compris l'éducation, les soins de santé, l'emploi, les sports de compétition et l'accès aux services publics, et s'attaquer à cette discrimination par le biais d'initiatives antidiscriminatoires pertinentes. La résolution 552 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) affirme que les personnes intersexuées en Afrique sont égales devant la loi et doivent donc être traitées avec dignité et bénéficier d'une protection égale devant la loi.

De même, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, par sa résolution 55, *Lutte contre la discrimination, la violence et les pratiques préjudiciables à l'encontre des personnes intersexuées,* encourage les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes, à redoubler d'efforts pour lutter contre la discrimination, la violence et les pratiques préjudiciables à l'encontre des personnes dont les caractéristiques sexuelles varient de manière innée. La résolution appelle à s'attaquer aux causes profondes, telles que les stéréotypes, la diffusion d'idées fausses et d'informations inexactes, la stigmatisation et les tabous. Elle invite également les États à s'efforcer de garantir le meilleur état de santé physique et mentale possible aux personnes présentant des variations innées des caractéristiques sexuelles.

Le rapporteur spécial sur la torture appelle tous les États à abroger toute loi autorisant des traitements
intrusifs et irréversibles, y compris la chirurgie de normalisation

génitale forcée, la stérilisation involontaire, l'expérimentation contraire à l'éthique, l'exhibition médicale, les "thérapies réparatrices" ou les "thérapies de conversion", lorsqu'elles sont appliquées ou administrées sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Ce rapport appelle également les États à proscrire la stérilisation forcée ou contrainte en toutes circonstances et à fournir une protection spéciale aux personnes appartenant à des groupes marginalisés.

Il est important de noter que les efforts de plaidoyer des organisations intersexes sont essentiels à la sensibilisation et à la promotion des réformes juridiques. Le rôle des militants intersexes dans la remise en cause des pratiques médicales néfastes et dans la défense de la reconnaissance et de la protection juridiques est très important Holmes (2011). Ces efforts ont conduit à des changements progressifs dans certains pays, où des réformes juridiques ont été introduites pour empêcher les chirurgies non consensuelles et pour reconnaître les droits des personnes intersexuées à s'auto-identifier.

2.3. Système et pratiques de soins de santé

L'approche du système de santé à l'égard des variations intersexes est souvent entravée par un manque deformation et de lignes directrices éthiques pour les prestataires de soins de santé. Garland et Slokenberga (2020) soulignent la nécessité de mettre en place des programmes complets d'éducation et de formation afin de doter les praticiens médicaux des connaissances et de la sensibilité nécessaires pour fournir des soins appropriés aux personnes intersexuées. Ils appellent également à l'élaboration de lignes directrices éthiques qui donnent la priorité au consentement éclairé et au bien-être à long terme des personnes intersexuées. Les personnes intersexuées sont confrontées à de nombreux obstacles dans l'accès aux soins de santé, notamment la discrimination, les contraintes financières et le manque de services spécialisés. Creighton (2014) souligne comment ces obstacles contribuent aux disparités et aux mauvais résultats en matière de santé pour les personnes intersexuées. La littérature suggère que la levée de ces barrières nécessite des changements systémiques dans les politiques de santé, y compris la garantie d'une couverture d'assurance pour les soins liés à l'intersexualité et la création d'environnements favorables dans les établissements médicaux.

2.4. Revue de la littérature sur les études intersexes en Afrique

Les personnes intersexuées sont souvent mal comprises et stigmatisées dans de nombreuses cultures africaines. Amadiume (1987) et Oyěwùmí (1997) expliquent que les sociétés africaines traditionnelles ont toujours reconnu la diversité des sexes, mais que les influences coloniales et postcoloniales ont renforcé la rigidité de la catégorisation des sexes. Ces influences ont contribué à la stigmatisation et à la marginalisation des

personnes intersexuées, qui sont souvent considérées comme des anomalies ou soumises à des superstitions et à des mythes.

Les études anthropologiques donnent un aperçu de la manière dont les personnes intersexuées sont perçues et traitées dans diverses communautés africaines. Njambi (2009) explore l'intersection du genre, de la culture et du colonialisme, en soulignant comment les conceptions indigènes du sexe et du genre ont été perturbées par la domination coloniale. L'imposition de normes médicales et juridiques occidentales a conduit à la pathologisation et à la marginalisation des personnes intersexuées, contrastant avec certaines pratiques précoloniales qui auraient pu être plus favorables à la diversité des genres.

2.4.1. Prévalence de l'intervention chirurgicale intersexe/(IGM)

Des recherches ont montré que l'intervention médicale intersexe (IGM) est un problème important dans plusieurs pays d'Afrique. Ces interventions chirurgicales non consenties sont souvent pratiquées sur des nourrissons et des enfants afin de conformer leur corps aux normes binaires de genre. Creighton et Minto (2001) soulignent que ces interventions peuvent avoir de graves conséquences physiques et psychologiques, notamment des douleurs chroniques, des cicatrices et des traumatismes. Liao, Wood et Creighton (2015) évoquent les lacunes de l'enseignement médical et le manque de services de santé spécialisés pour les patients intersexués. De nombreux prestataires de soins de santé ne sont pas équipés pour traiter les cas d'intersexualité de manière éthique ou compétente, ce qui conduit à des diagnostics erronés, à la stigmatisation et à des traitements inappropriés.

Les personnes intersexuées en Afrique sont confrontées à d'importants défis juridiques en raison de l'absence de protections et de reconnaissances spécifiques. Carpenter (2016) note que la plupart des pays africains n'ont pas de lois qui protègent explicitement les droits des personnes intersexuées, ce qui les rend vulnérables à la discrimination et aux violations des droits de l'homme. Ce vide juridique fait qu'il est difficile pour les personnes intersexuées d'obtenir des documents juridiques exacts et d'accéder aux services essentiels.

Les organisations de défense des droits de l'homme et les groupes de défense des personnes intersexuées se sont efforcés de résoudre ces problèmes. Aniekwu (2006) souligne l'importance du plaidoyer dans la promotion des réformes juridiques et la protection des droits des personnes intersexuées. Les efforts déployés par des groupes tels que l'Intersex Society of South Africa (ISSA), Intersex Nigeria, Ivy Foundation, Intersex Zambia, Intersex Persons Society of Kenya, SIPD Uganda et des organisations internationales ont permis d'attirer l'attention sur la situation critique des personnes intersexuées et de faire pression en faveur de changements de politique.

En Afrique, les personnes intersexuées sont souvent confrontées à une stigmatisation et à une discrimination sévères. Reis (2007) explique comment les croyances religieuses, les idées fausses et les normes sociétales et culturelles influencent les attitudes à l'égard des personnes intersexuées. Cette stigmatisation conduit à l'exclusion sociale, à la violence et à des problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression et les luttes identitaires.

2.5. Aperçu des études sur l'intersexualité au Nigeria

Au Nigeria, comme dans de nombreux pays africains, les croyances culturelles et les normes sociétales mettent fortement l'accent sur les rôles binaires du sexe et du genre, marginalisant souvent les personnes dont les caractéristiques sexuelles ne sont pas conformes à ces normes. Les variations intersexuelles font l'objet d'une stigmatisation généralisée, qui conduit à l'exclusion sociale, à la discrimination, voire à la violence à l'encontre des personnes intersexuées.

les personnes intersexuées. Les croyances traditionnelles et les superstitions peuvent contribuer à des idées fausses sur les traits intersexuels, ce qui complique encore l'acceptation par la société.

Des interventions médicales non consensuelles, y compris des chirurgies visant à modifier les organes génitaux des enfants intersexués pour les faire correspondre aux normes sexuelles binaires, sont signalées au Nigeria, comme dans le cas du gouvernement de l'État de Kano qui a parrainé 7 enfants et adolescents pour qu'ils subissent une procédure chirurgicale "corrective" non consensuelle sans information adéquate ou compréhension critique des complications potentielles (vanguardngr). Ces pratiques sont souvent effectuées sans consentement éclairé et peuvent entraîner des dommages physiques et psychologiques à long terme.

Au Nigeria, les personnes intersexuées ne bénéficient d'aucune protection juridique spécifique ni d'aucune reconnaissance de leurs besoins et identités uniques. Cette absence de cadre juridique rend les personnes intersexuées vulnérables à la discrimination, au déni de droits et à la difficulté d'obtenir des documents juridiques qui reflètent leur véritable identité. Les efforts de sensibilisation déployés par les organisations locales et internationales commencent à combler ces lacunes, mais il reste encore beaucoup à faire. Ces efforts visent à sensibiliser aux questions liées à l'intersexualité, à plaider en faveur de réformes juridiques et à promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes intersexuées au Nigeria. Bien que les études spécifiques sur les questions d'intersexualité au Nigeria soient limitées, des preuves anecdotiques et des rapports d'organisations de défense soulignent le besoin urgent de recherches supplémentaires pour documenter les variations intersexuelles, les besoins des personnes intersexuées, l'impact des

interventions médicales chirurgicales et les expériences des personnes intersexuées dans les différentes régions du Nigeria. Des organisations telles qu'Intersex Nigeria et d'autres groupes de défense des droits de l'homme s'efforcent de sensibiliser le public aux questions liées à l'intersexualité, de plaider en faveur de changements politiques et d'apporter un soutien aux personnes intersexuées et à leurs familles. Ces efforts sont essentiels pour faire progresser les protections juridiques, améliorer l'accès aux soins de santé et favoriser l'acceptation sociétale de la diversité intersexuelle au Nigeria.

Les interventions médicales inutiles (IGM) sont un problème répandu et très préoccupant au Nigeria. Ces interventions sont souvent pratiquées sur des nourrissons et des enfants intersexués sans que leurs parents soient pleinement informés des conséquences sanitaires de ces interventions médicales. Les interventions chirurgicales de routine visant à modifier l'apparence génitale des personnes intersexuées sont pratiquées sans leur consentement et souvent sans que les parents soient pleinement informés des risques potentiels et des conséquences à long terme. L'objectif de ces interventions médicales est de "normaliser" l'apparence génitale et les hormones des personnes intersexuées afin qu'elles correspondent aux attentes de la société en matière de corps masculin et féminin. Ces interventions médicales devraient être reportées, si elles ne sont pas absolument nécessaires, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge adulte et puisse donner son consentement en connaissance de cause.

Ces procédures peuvent inclure des réductions clitoridiennes, des vaginoplasties et des gonadectomies, entre autres. Les complications sanitaires résultant d'interventions médicales inutiles peuvent être graves et durer toute la vie. Les personnes intersexuées qui subissent ces interventions chirurgicales sont souvent confrontées à des douleurs chroniques, à une perte de sensations sexuelles, à des cicatrices et à des complications liées à la miction et à la santé reproductive. En outre, certaines personnes intersexuées doivent subir d'autres interventions chirurgicales tout au long de leur vie pour remédier aux complications résultant des procédures initiales, ce qui entraîne un traumatisme médical et une souffrance continus. En effet, de nombreux adultes intersexués qui ont subi des interventions de "normalisation" dans l'enfance ont fait part de leur insatisfaction quant à leur apparence, aux cicatrices, à la douleur et à la diminution, voire à l'absence, de la fonction sexuelle. Berry et Monro (2022)

Les traits intersexuels sont souvent pathologisés comme des conditions médicales qui doivent être corrigées, plutôt que d'être compris comme des variations naturelles de la biologie humaine. Cette pathologisation pousse la communauté médicale à recommander et à pratiquer des interventions chirurgicales et des traitements visant à "réparer" les corps intersexués, plutôt qu'à soutenir la santé et le bien-être des personnes intersexuées.

Le secret qui entoure l'intersexualité et les interventions médicales ne fait qu'exacerber les difficultés rencontrées par les personnes intersexuées. Les dossiers médicaux sont souvent tenus secrets et les parents ne sont pas toujours pleinement informés de l'état de leur enfant ou de la nature des interventions chirurgicales pratiquées. Ce manque de transparence empêche les personnes intersexuées d'accéder à leurs antécédents médicaux et de comprendre toute l'étendue des interventions qu'elles ont subies, ce qui les empêche de rechercher des soins et un soutien appropriés.

L'offre de soins médicaux spécialisés et de conseils pour les personnes intersexuées est limitée au Nigeria. Les prestataires de soins de santé qui connaissent les variations intersexuelles et sont capables de fournir des soins complets sont rares. Ce manque de services spécialisés signifie que les personnes intersexuées ne reçoivent souvent pas l'attention médicale, les services et le soutien psychologique dont elles ont besoin.

L'absence de lignes directrices et de protocoles établis pour le traitement éthique et consensuel des personnes intersexuées constitue une lacune importante dans le système de santé. En l'absence de lignes directrices claires, les prestataires de soins de santé peuvent s'appuyer sur des pratiques dépassées et préjudiciables qui ne donnent pas la priorité au consentement ou au bien-être des patients intersexués.

L'élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices et de protocoles éthiques sont essentielles pour garantir que les personnes intersexuées reçoivent des soins respectueux et appropriés.

3.0. Méthodologie

Cette recherche aborde les études sur l'intersexualité au Nigeria par le biais d'une méthode complète et systématique de collecte de données quantitatives, d'analyse des résultats et de plaidoyer en faveur de réformes politiques. Cette approche vise à combler les lacunes en matière de connaissances et de prévalence des interventions chirurgicales sur les personnes intersexuées, à sensibiliser et à promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes intersexuées. Des méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives ont été utilisées dans le cadre de cette recherche.

Identifier les hôpitaux du Nigeria qui ont connu des naissances intersexuées ou qui ont pratiqué des interventions chirurgicales et d'autres interventions médicales. Une cartographie d'au moins 50 hôpitaux stratégiques dans les six zones géopolitiques du Nigeria a été réalisée et des données ont été collectées sur la prévalence des cas d'intervention chirurgicale sur l'intersexualité ou d'autres interventions médicales à l'aide de questionnaires structurés. La sélection des hôpitaux et des régions du Nigeria pour l'étude des questions liées à l'intersexualité est cruciale pour garantir une collecte de données complète, une représentation des diverses pratiques de soins de santé et des variations régionales.

La sélection des hôpitaux pour l'étude sur les questions d'intersexualité au Nigeria implique un examen minutieux de divers critères afin de garantir une collecte de données complète et une représentation des pratiques de soins de santé dans les différentes régions. Le Nigeria est divisé en six zones géopolitiques: Centre-Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Sud et Sud-Ouest.

Chaque zone possède des caractéristiques culturelles, religieuses et socio-économiques uniques qui influencent la prestation des soins de santé et les perceptions sociétales des variations intersexes. En sélectionnant des hôpitaux dans chaque zone, l'étude garantit une compréhension complète de la prévalence des naissances intersexuées, de la prévalence des interventions chirurgicales et médicales, et des directives des prestataires de soins de santé sur les naissances intersexuées au Nigéria.

Les hôpitaux sélectionnés pour l'étude sont choisis stratégiquement en fonction de leur réputation, de leur capacité et de leurs antécédents en matière de gestion des cas d'intersexualité. Ce critère permet des'assurer de l'avis de prestataires de soins de santé expérimentés dans les soins aux personnes intersexuées et de la disponibilité de données pertinentes pour l'étude.

l'analyse. Pour l'aspect qualitatif de la recherche, après la collecte des données à l'aide d'un questionnaire structuré, des entretiens ont également été menés avec 13 médecins afin d'obtenir un aperçu des questions relatives à l'intersexualité au Nigeria. Ces 13 répondants

sont répartis dans les six zones géopolitiques, à raison de deux répondants par zone géopolitique, à l'exception du sud-ouest, où trois répondants ont été interrogés en raison de la concentration de la population à Lagos (Nigeria).

3.1. Cartographie des hôpitaux et des médecins.

Pour qu'un établissement soit qualifié pour participer à cette étude, il doit s'agir d'un hôpital, qu'il soit privé, fédéral ou d'État, qui dispose de professionnels formés à l'étude des cas d'intersexualité. L'approche de la recherche donne la priorité aux normes éthiques en faisant appel à des professionnels médicaux qualifiés.

La recherche examine attentivement deux spécialités principales par établissement, à savoir les spécialistes en pédiatrie et les obstétriciens et gynécologues (spécialistes en gynécologie-obstétrique), mais elle prend également en considération quelques professionnels qui ont vu des cas d'intersexualité, notamment des médecins de famille, des chirurgiens pédiatres et des chirurgiens généralistes.

3.2. Collecte et analyse des données

Pour recueillir des données empiriques sur l'impact des pratiques, la prévalence des interventions chirurgicales et les défis sociétaux auxquels sont confrontées les personnes intersexuées au Nigeria, nous avons employé 6 médecins pour chacune des six zones géopolitiques du Nigeria, qui supervisent la zone et assurent le recrutement d'au moins deux personnes par hôpital/état qui participeront à l'enquête.

Ceci afin de garantir l'inclusion des hôpitaux de chacune des six zones géopolitiques du Nigeria.

Nous avons recueilli des données à l'aide d'un questionnaire structuré administré aux prestataires de soins de santé afin de collecter des données quantitatives sur les attitudes, les pratiques et les perceptions liées à la prévalence et aux droits en matière d'interventions chirurgicales sur les personnes intersexuées.

Pour recueillir des données qualitatives afin de mieux comprendre les questions liées à l'intersexualité, des entretiens ont été menés avec des personnes interrogées dans six zones géopolitiques. Pour protéger la confidentialité des informations sur les patients et les personnes interrogées, nous avons anonymisé les données lors de la collecte, de l'extraction et de l'analyse, en veillant à respecter les directives éthiques.

Nous avons analysé les données recueillies pour en tirer des enseignements significatifs et formuler des recommandations fondées sur des données probantes en utilisant des

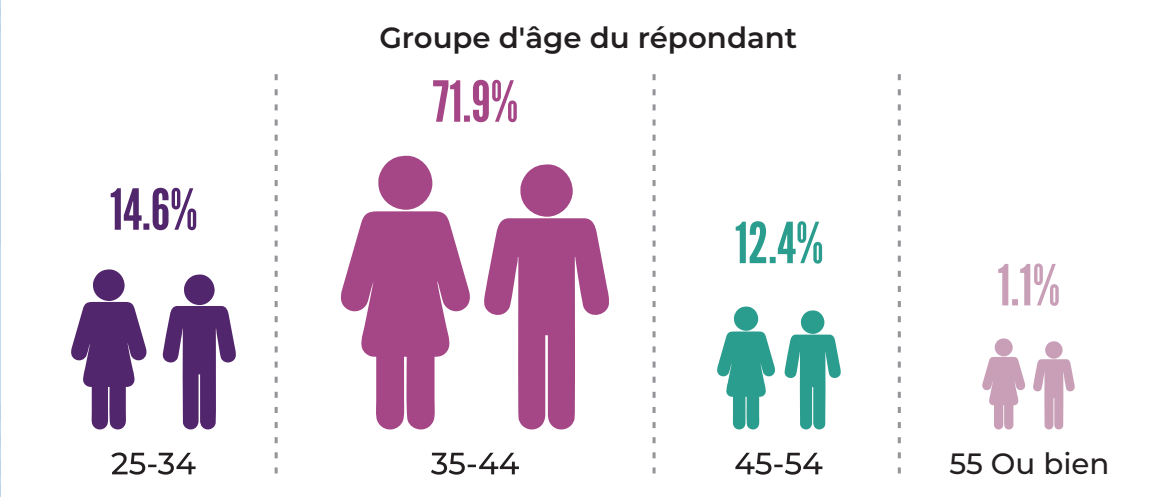
méthodes statistiques. Pour analyser les informations, telles que la prévalence de l'intervention chirurgicale et la fréquence des interventions médicales, nous avons veillé à ce que les données que les questions vérifient entre elles soient exactes.

L'application des statistiques descriptives pour calculer les fréquences, les pourcentages et les moyennes, afin de résumer les données quantitatives relatives à l'intervention chirurgicale et aux autres interventions médicales a été utilisée. L'analyse a été effectuée à l'aide de logiciels d'analyse statistique (Excel et STATA). L'analyse qualitative a été réalisée à l'aide de NVivo, qui permet d'organiser, de coder et d'analyser le texte afin d'identifier des modèles et des thèmes.

4.0. Constatations et discussion

4.1. Démographie du répondant

Des professionnels de la santé ont répondu à l'enquête menée dans 50 établissements des six zones géopolitiques du Nigeria. La démographie des personnes interrogées est présentée ci-dessous.

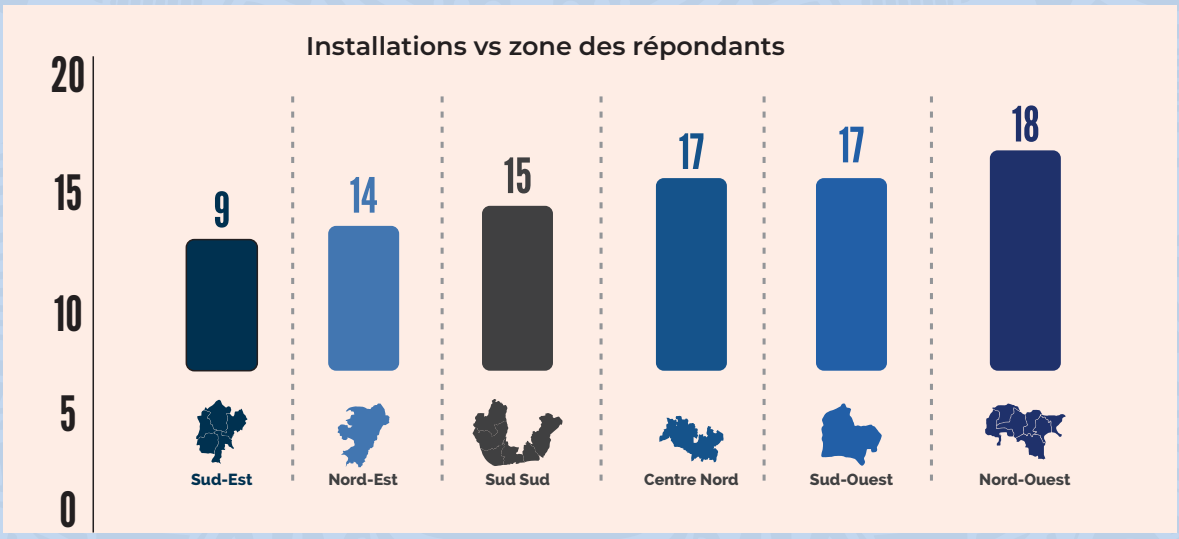


La figure 1. Montre la tranche d'âge des personnes interrogées.

La tranche d'âge "35-44 ans" est la plus répandue, avec environ 71,9% des personnes interrogées. Cela montre une forte concentration ou représentation des médecins en début de carrière. Les tranches d'âge "25-34 ans" et "45-54 ans" représentent respectivement 14,6% et 12,4% des répondants. Seul un petit pourcentage de "55 ans ou plus", soit environ 1% des répondants, a participé à l'enquête.

4.2. Représentation régionale etspécialités

Les six zones géopolitiques du pays ont été représentées, avec une moyenne de deux répondants par État. Cela signifie qu'en moyenne, chaque État a au moins deux répondants à l'enquête.



La figure 2. Montre le nombre d'installations dans chaque zone des personnes interrogées.

La figure 2 ci-dessus montre que la région du Nord-Ouest compte le plus grand nombre de répondants (18), tandis que la région du Sud-Est en compte le moins (9). Les régions du centre-nord et du sud-ouest comptent chacune 17 répondants, tandis que les régions du sud-sud et du nord-est ont le moins de répondants.

ont respectivement 15 et 14 répondants. Dans l'ensemble, toutes les zones du pays sont représentées, avec au moins un répondant par État.

Les établissements de santé dans lesquels les personnes interrogées exercent sont tous des établissements publics et tertiaires, ce qui indique que les personnes interrogées dans le cadre de cette étude sont toutes des professionnels issus du secteur public au Nigeria.

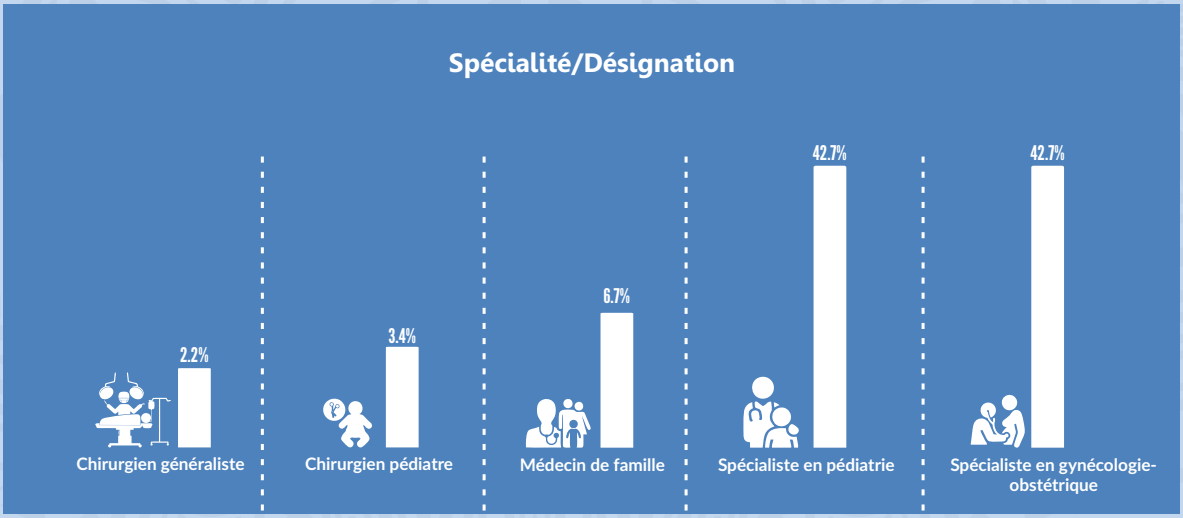


Figure 3: Indique la désignation et la spécialité de toutes les personnes interrogées.

Les spécialités les plus représentées sont les spécialistes en pédiatrie (42,7%) et les spécialistes en gynécologie-obstétrique (42,7%). Les médecins de famille représentent environ 6,7 % de l'échantillon, les chirurgiens pédiatres environ 3,4 % et les chirurgiens généralistes 2,2 %. La représentation de l'ensemble des données est fortement biaisée en faveur des spécialistes en pédiatrie et en gynécologie-obstétrique, ce qui indique une concentration sur ces spécialités.

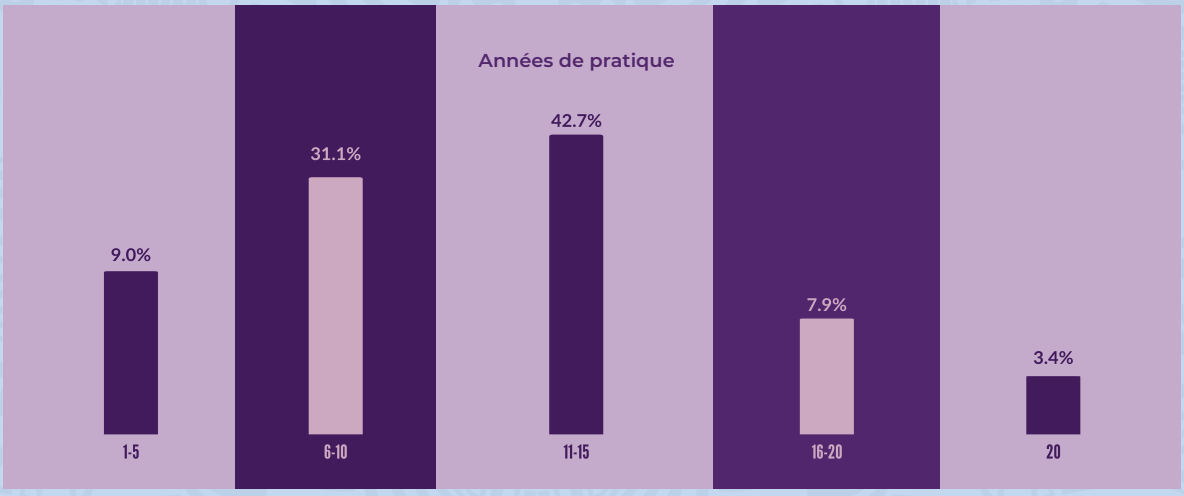


Figure 4: Indique le nombre d'années de pratique des personnes interrogées

La tranche des 11-15 ans est la plus courante, avec près de la moitié des personnes interrogées (42,7%). La tranche des 6-10 ans est également très représentée (37,1 %), ce qui indique que la plupart des répondants ont une expérience moyenne à relativement élevée dans leur domaine. Peu de répondants se situent dans la tranche des 16-20 ans (7,9 %) et (9,0 %) se situent dansla tranche des 16-20 ans.

de 1 à 5 ans. Un peu plus de 3,4 % des personnes interrogées ont plus de 20 ans d'expérience.

4.3. Sensibilisation et connaissance de l'intersexualité

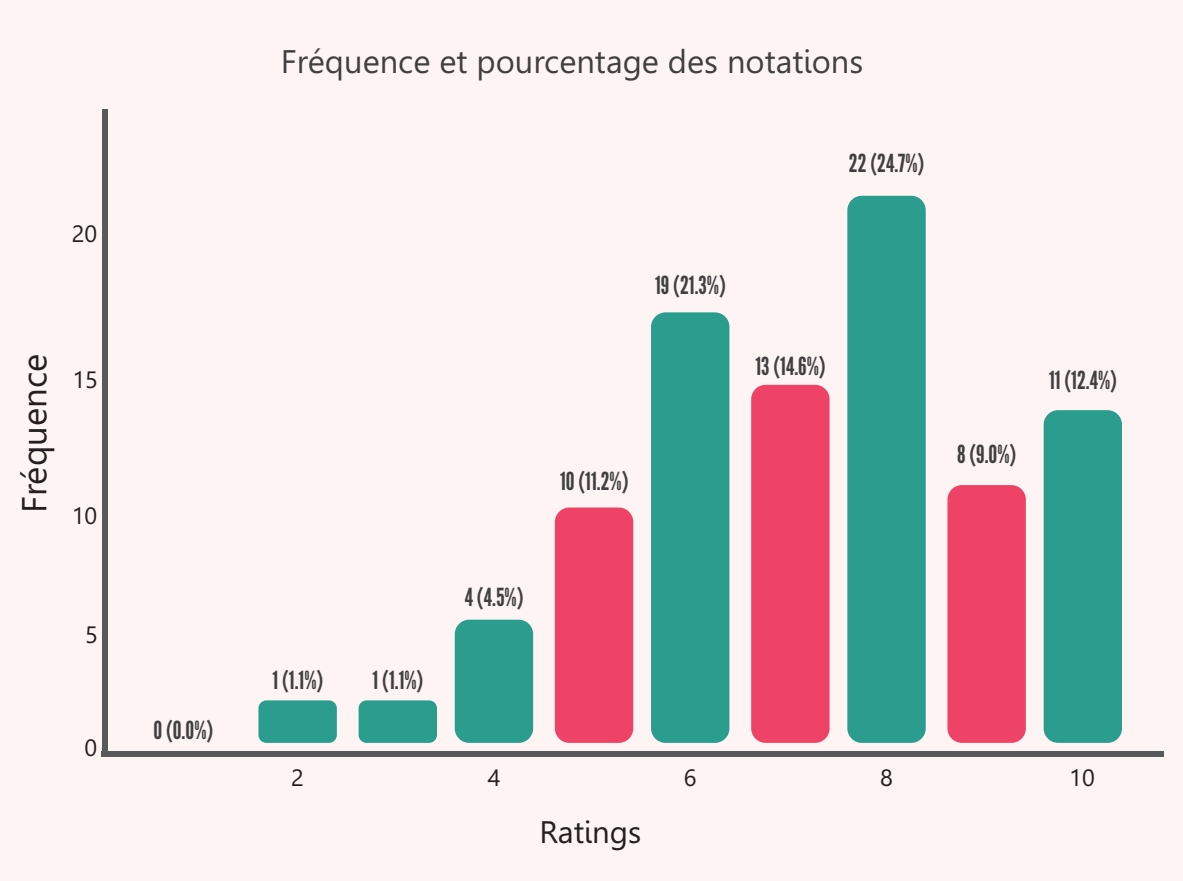


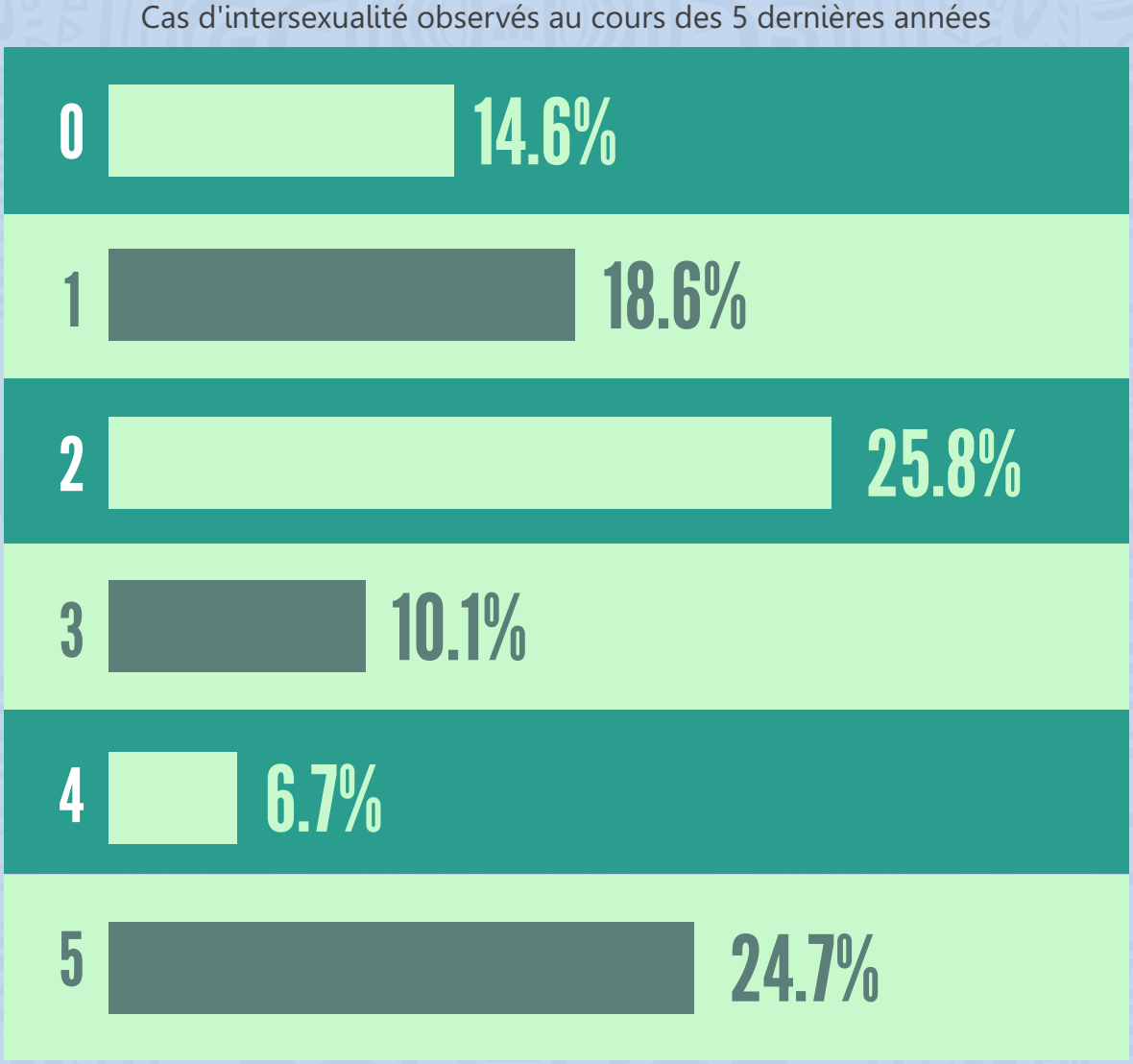
Figure 5: Montre l'échelle des connaissances des personnes interrogées sur l'intersexualité.

La figure 5 montre qu'environ 54 (61%) des répondants se situent sur une échelle de 7 à 10, ce qui signifie qu'ils se considèrent comme très bien informés sur l'intersexualité.

33 répondants, soit environ 37%, se situent entre 4 et 6, ce qui suggère qu'un nombre important de répondants ont des connaissances moyennes.

Quelques-uns, soit 2 %, se situent entre 2 et 3 et considèrent qu'ils n'ont qu'une faible connaissance de l'intersexualité.

4.4. Prévalence des naissances intersexuées



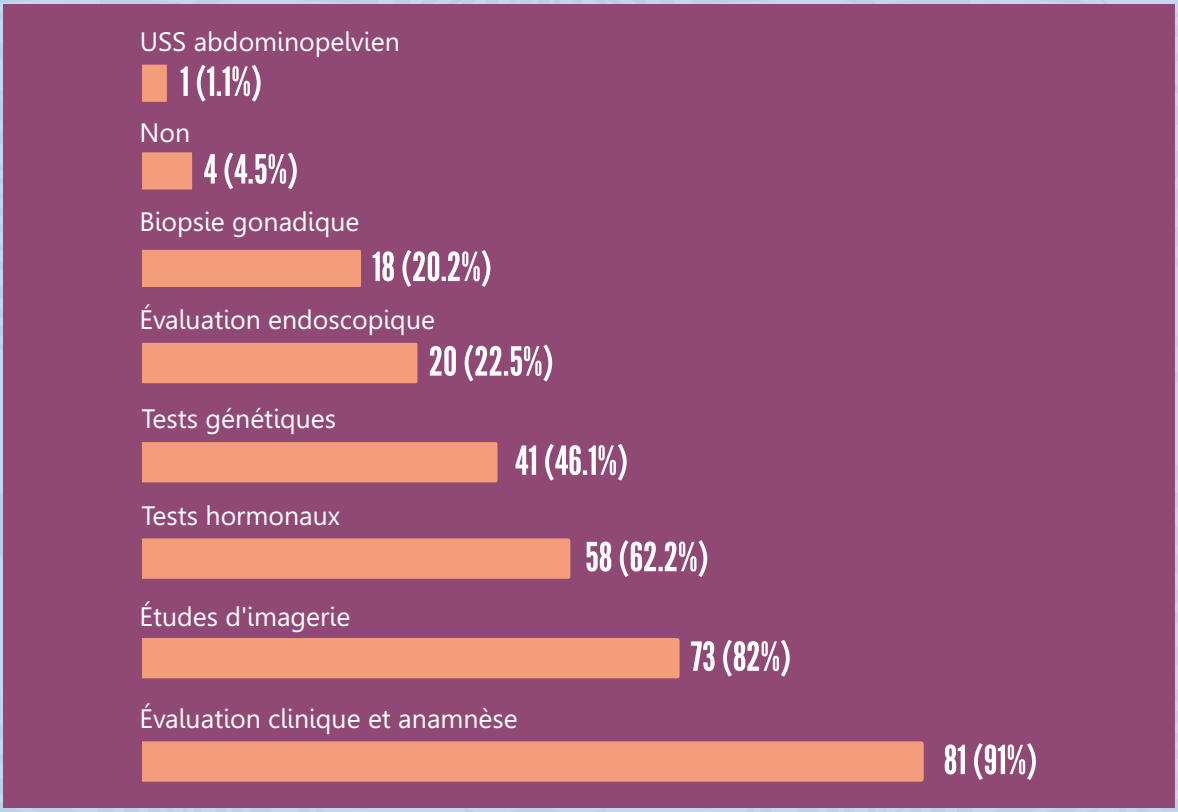
La figure 6 présente les cas d'intersexualité observés au cours des cinq dernières années par les personnes interrogées.

Environ 15% des personnes interrogées n'ont vu aucun cas d'intersexualité au cours des 5 dernières années de leur carrière professionnelle, et 18% des personnes interrogées n'ont vu qu'un seul cas d'intersexualité.

L'observation la plus fréquente concerne les personnes qui ont vu deux cas, soit environ 26 % des répondants. 10 % des répondants ont vu 3 cas d'intersexualité et 7 % des répondants ont vu 4 cas d'intersexualité au cours des 5 dernières années. Notamment, un quart, soit 25 % des personnes interrogées,ont vu 5 cas d'intersexualité ou plus au cours des 5 dernières années de leur carrière.

Cela montre que lafréquence des naissances intersexes est très importante, puisque 85 % des personnes interrogées ont vu au moins un cas d'intersexualité au cours des cinq dernières années.

4.5. Évaluation et traitement cliniques des personnes intersexuées



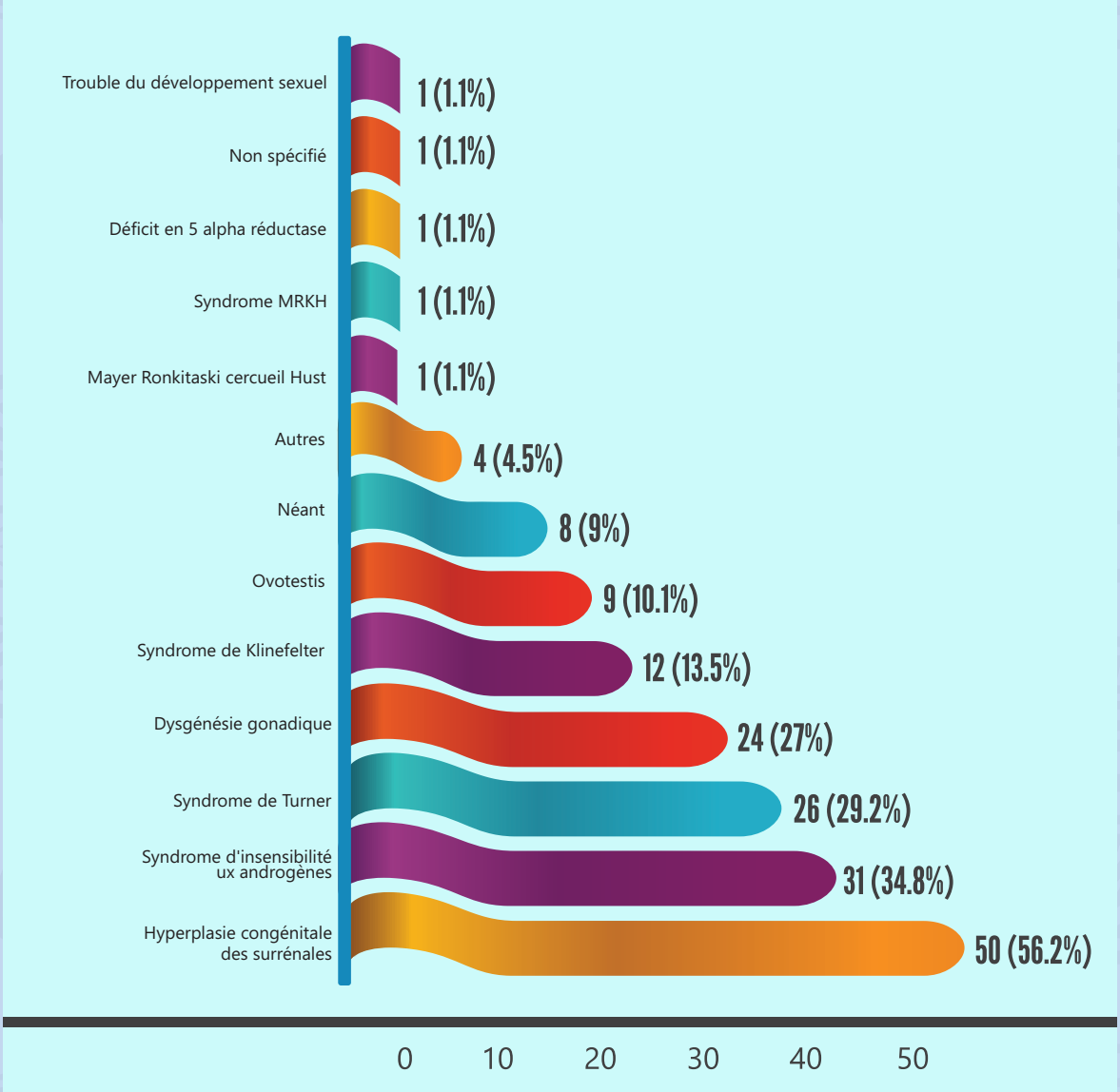
La figure 7 présente les critères diagnostiques et les méthodes utilisées pour identifier l'intersexualité.

Étant donné que les personnes interrogées sont autorisées à sélectionner plusieurs options applicables dans leur établissement, l'évaluation clinique et l'anamnèse (91 %) et les études d'imagerie (82 %) sont les méthodes de diagnostic les plus fréquemment utilisées, ce qui indique une forte dépendance à l'égard de ces pratiques cliniques pour l'identification de l'intersexualité. Les tests hormonaux (65,2 %) sont également une méthode de diagnostic courante, ce qui témoigne de leur importance dans l'évaluation de l'intersexualité. On constate également que les tests génétiques, utilisés par près de la moitié des personnes interrogées (46 %), constituent une autre méthode de diagnostic. L'évaluation endoscopique (22,5 %) et la biopsie gonadique (20,2 %) sont moins couramment utilisées, mais restent des méthodes notables pour certains cas spécifiques. Un faible pourcentage de répondants (1,1 %) utilise des méthodes telles que la recherche de corps de Barr ou l'échographie abdominopelvienne.

Figure 8 : indique s'il existe des protocoles ou des lignes directrices spécifiques pour le diagnostic de l'intersexualité.

Vingt-et-un répondants (23,6 %) ont révélé qu'il existe des protocoles ou des lignes directrices spécifiques pour le diagnostic de l'intersexualité dans leur hôpital, tandis que soixante-huit répondants (76,4 %) ont indiqué qu'il n'existe pas de protocoles ou de lignes directrices spécifiques pour le diagnostic de l'intersexualité dans leur hôpital.

Cela montre que la majorité des établissements publics ne disposent pas de protocoles ou de lignes directrices spécifiques pour le diagnostic de l'intersexualité. Une analyse approfondie montre que la plupart des 76,4 % des États du Nigeria n'ont pas de protocoles ou de lignes directrices spécifiques en place dans leurs hôpitaux pour diagnostiquer les variations intersexuelles.



La figure 9 montre le diagnostic des cas vus par les personnes interrogées.

L'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est le diagnostic le plus fréquent, présent dans environ 56,2% des cas. Le syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA) est également un diagnostic courant, observé dans 34,8 % des cas. Le syndrome de Turner et la dysgénésie gonadique sont également prévalents, avec respectivement environ 26 % et 24 % des cas. Le syndrome de Klinefelter représente 12 % des cas diagnostiqués et l'ovotestis est noté dans 10,1 % des cas. Le syndrome de Mayer-Rokitansky-KüsterHauser (MRKH), le déficit en 5 alpha-réductase et le trouble du développement sexuel (DSD) sont relativement rares, chacun représentant moins de 1 ou 2 % des cas, et les autres ne représentent qu'une faible proportion (4,5 %).

Figure 10 : indique le diagnostic le plus récent consulté par la personne interrogée

L'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est le diagnostic le plus courant et le plus récent que la plupart des patients ont posé ; elle représente 47,6 % des cas. Le syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA) est le deuxième diagnostic récent le plus courant, avec 14,3 % des cas.

Le syndrome de Turner est signalé dans 10,7 % des cas. L'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est le diagnostic récent le plus répandu parmi les diagnostics déclarés, suivi du syndrome d'insensibilité aux androgènes (SAI) et du syndrome de Turner.

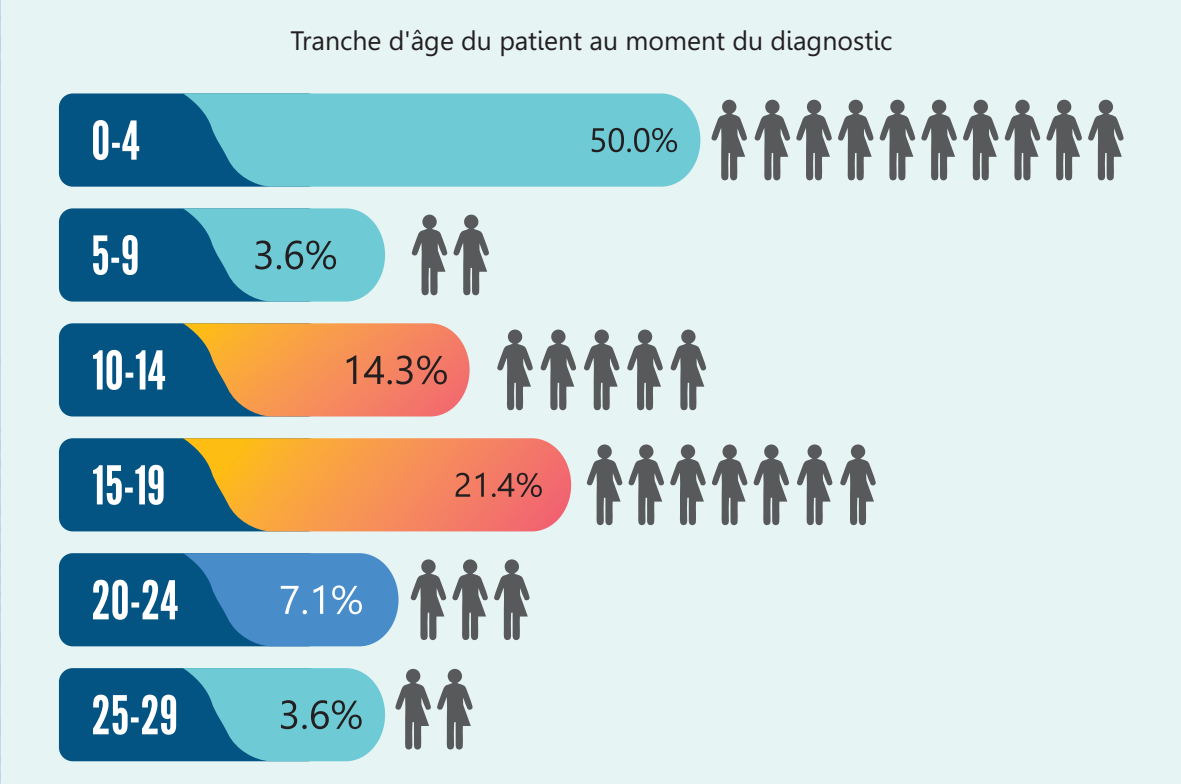


Figure 11: Montre l'âge du patient au moment où le diagnostic récent a été posé.

La plupart des cas diagnostiqués concernaient des patients âgés de 0 à 4 ans, ce qui représente 50 % des cas diagnostiqués récemment. Cela montre que la moitié des diagnostics posés concernent des enfants. La tranche d'âge des 15-19 ans représente 21,1 % des diagnostics, ce qui montre également qu'un nombre important de diagnostics sont posés pendant l'adolescence.

Le groupe d'âge des 10-14 ans représente environ 14,3 % des diagnostics. Environ 68 % des cas diagnostiqués concernent des personnes âgées de 1 à 14 ans, ce qui représente un pourcentage considérable de la population qui n'est pas en mesure de prendre des décisions concernant son corps.

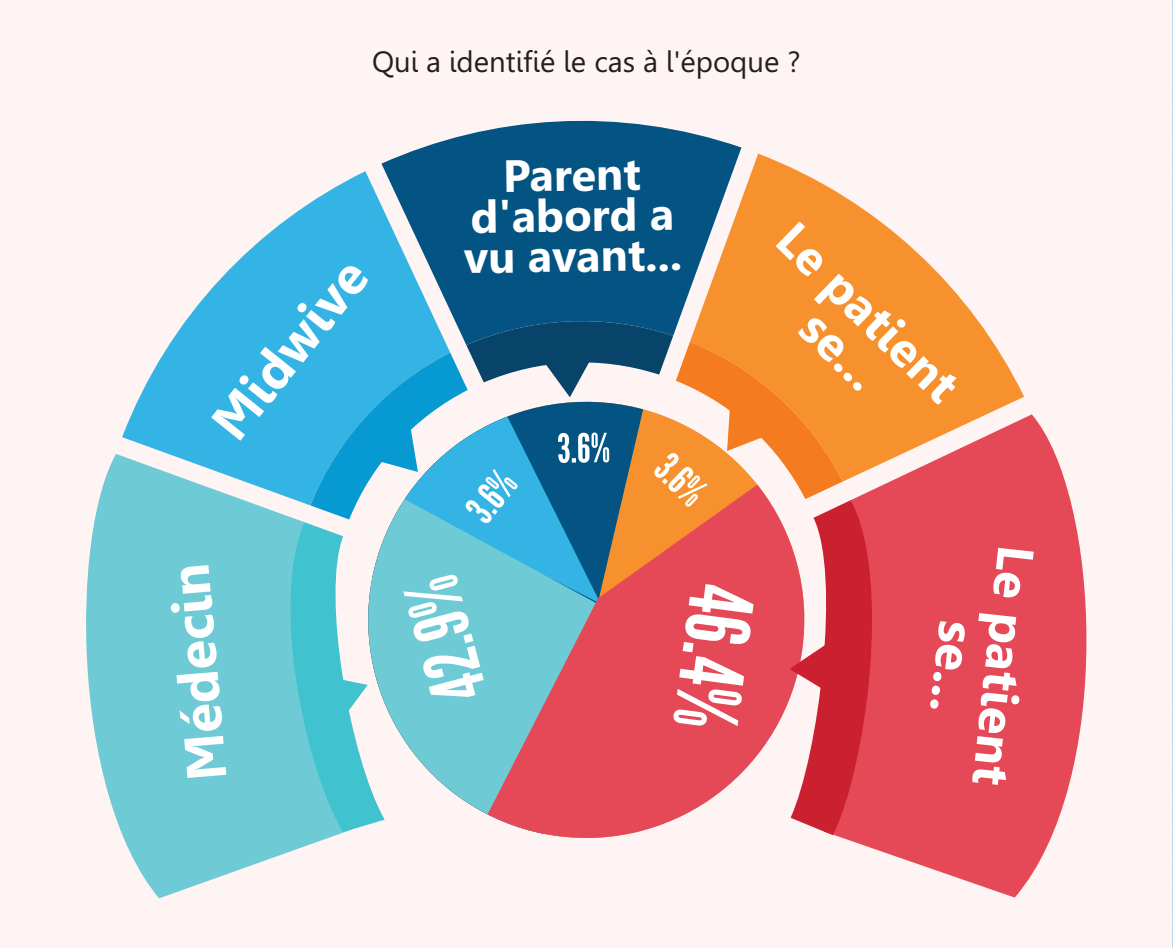
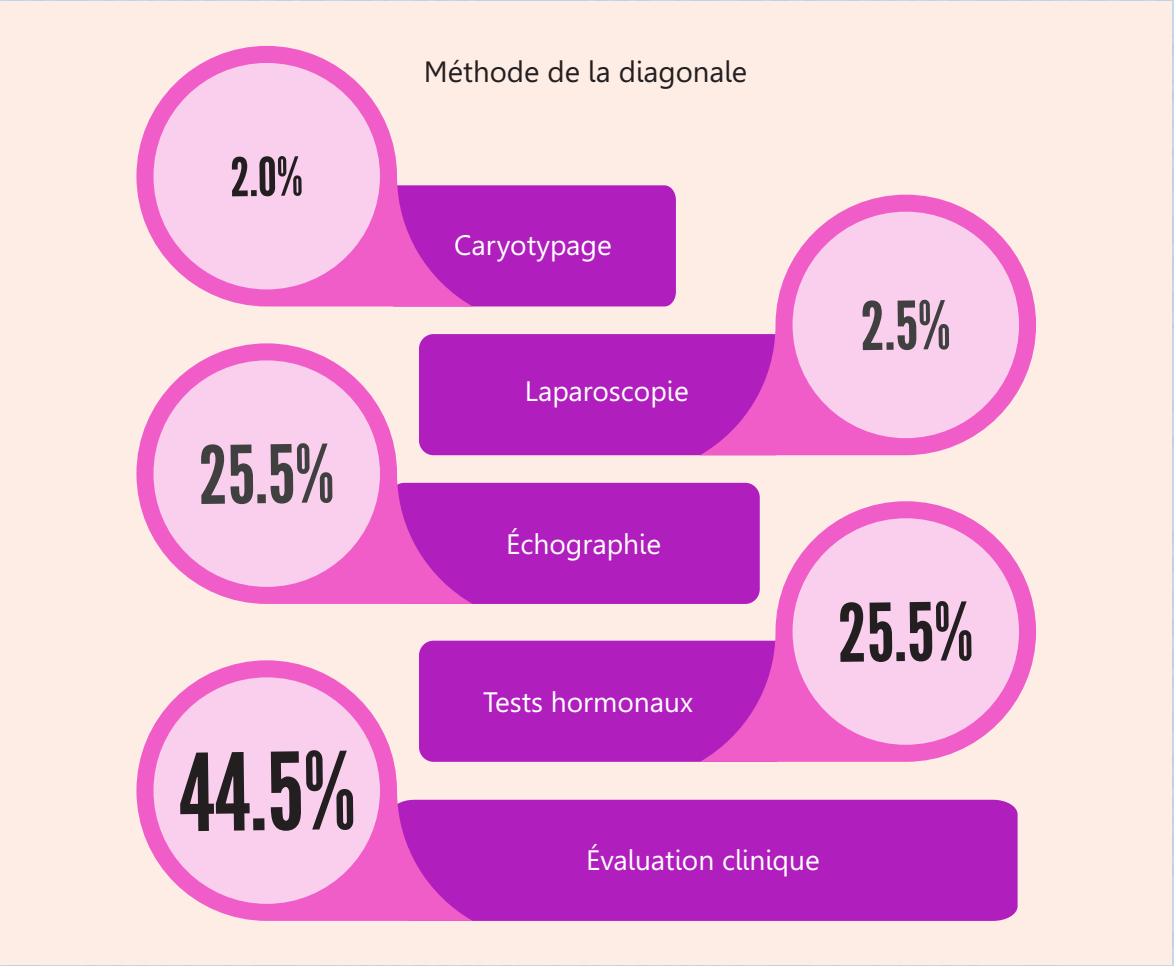


Figure 12: Réponses des personnes qui ont identifié le cas.

D'après la figure 12 ci-dessus, 46,4 % des cas d'intersexualité ont d'abord été identifiés par les parents, ce qui souligne le rôle de l'observation familiale dans l'identification précoce, tandis que les médecins représentent environ 43 %. Les sages-femmes et les patients eux-mêmes ont joué un rôle minime dans l'identification initiale, avec environ 4 % chacun.

"Il existe un récit d'une patiente sur le point de se marier qui souffrait d'une clitoromégalie remarquée à la naissance. Mais elle ne l'a présentée à l'hôpital qu'au moment où elle était censée se marier. Ses parents les ont d'abord consultés avant que le diagnostic ne soit posé par les médecins".



La figure 13 montre la méthode utilisée pour le diagnostic du cas le plus récent.

Les tests hormonaux, l'échographie, l'évaluation clinique et l'anamnèse sont les méthodes de diagnostic les plus courantes dans les cas récents, l'évaluation clinique étant la plus répandue.
La laparoscopie et le caryotypage sont également utilisés dans quelques cas. Les autres méthodes de diagnostic utilisées moins fréquemment sont la biopsie gonadique, l'IRM et les examens de laboratoire.

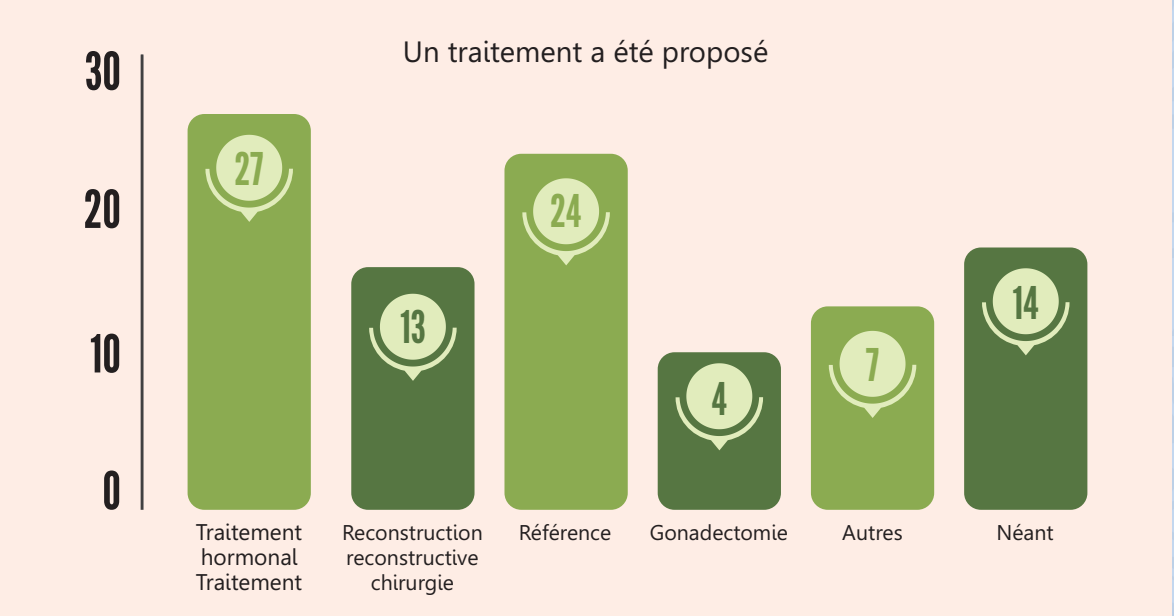


Figure 14: Shows the Medical interventions offered by professionals on the most recently seen case

Les interventions médicales proposées aux patients diagnostiqués montrent qu'une thérapie hormonale a été proposée dans 27 (30,3 %) des cas, ce qui en fait le traitement le plus courant. La chirurgie reconstructive pelvienne a été proposée dans 13 cas, soit 14,6 % des cas. Environ 24 (27%) cas ont été référés par le médecin. La gonadectomie a été proposée à 4 (4,5 %) des cas. D'autres interventions médicales non mentionnées représentent 7,9 % des cas.
et certains professionnels n'ont traité aucun cas.

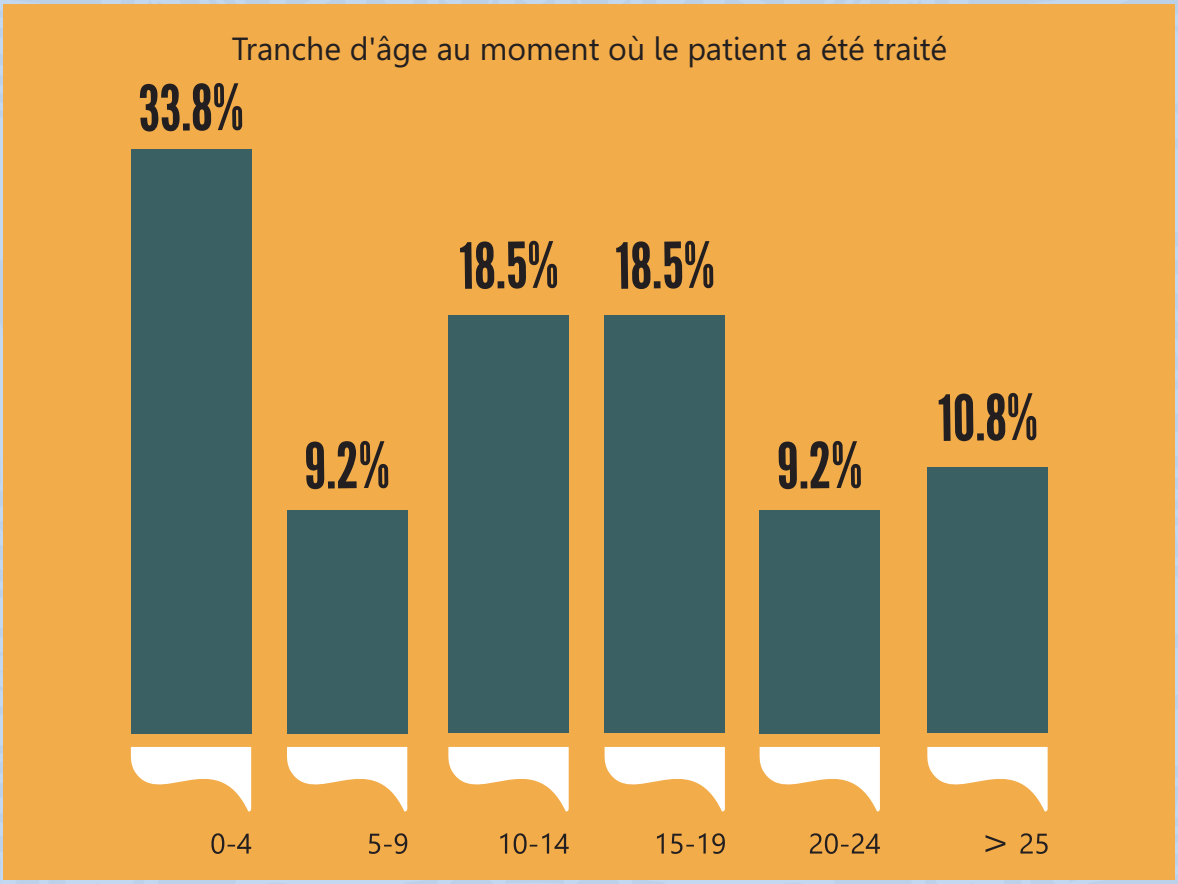


Figure 15: Montre l'âge de l'intersexe au moment des interventions médicales.

La plupart des interventions médicales effectuées récemment ont eu lieu dans la tranche d'âge des 0-4 ans, suivie par les tranches d'âge des 10-14 ans et des 15-19 ans. Les traitements sont moins fréquents dans les tranches d'âge supérieures. Même si plus de 10 % des patients ont été traités à plus de 25 ans.

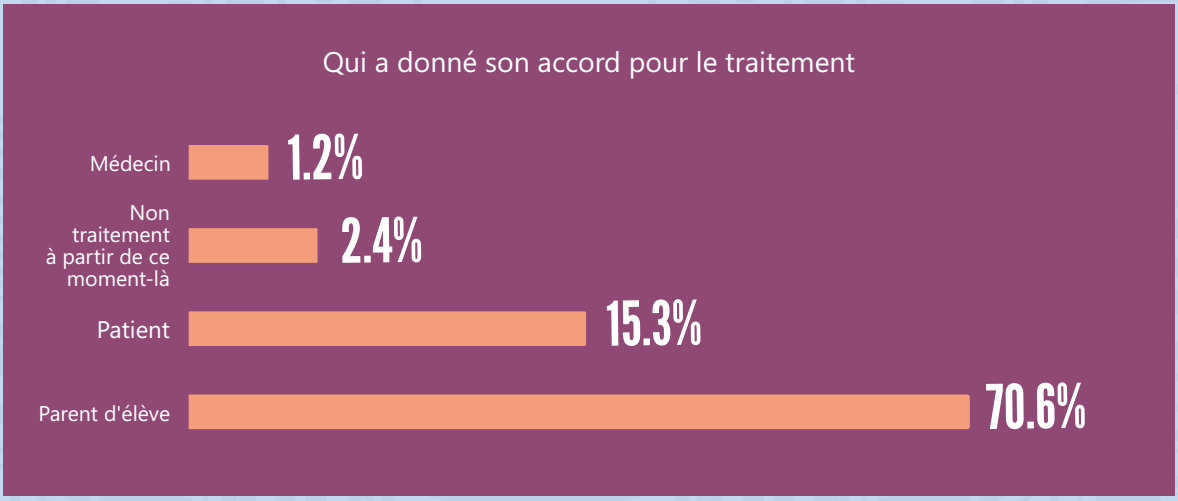


Figure 16: Indique qui a donné son consentement pour les interventions médicales.

Les consentements ont été donnés le plus souvent par les parents des enfants, soit environ 71% des cas,puis par les patients eux-mêmes pour les patients âgés de plus de 18 ans. Dans quelques cas, aucun traitement n'avait été administré au moment de la déclaration.

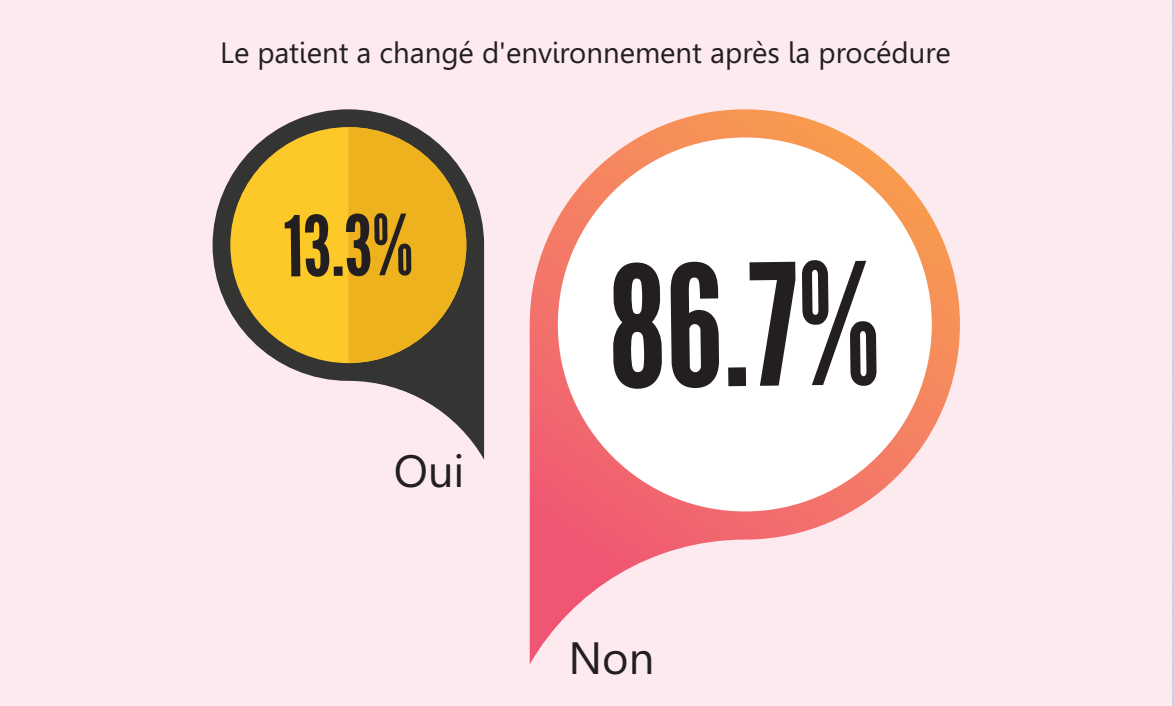


Figure 17: Indique si le patient a changé d'environnement après la procédure.

Le graphique ci-dessus montre que la plupart des patients n'ont pas changé d'environnement après la procédure. Quelques-uns, environ 13 %, ont changé d'environnement après la procédure.

4.6. Attitudes et pratiques des prestataires de soins de santé

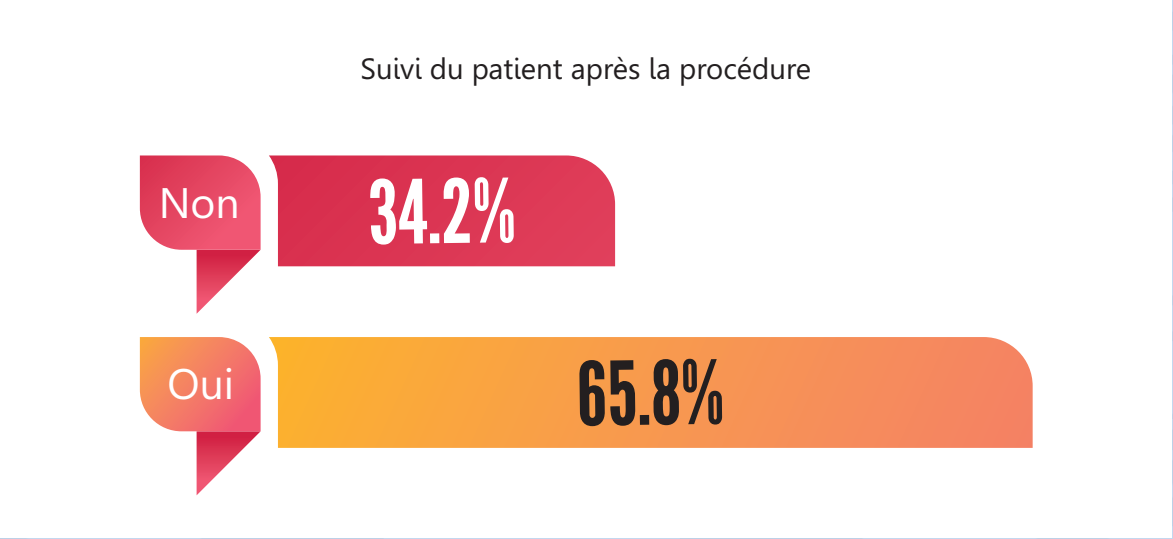
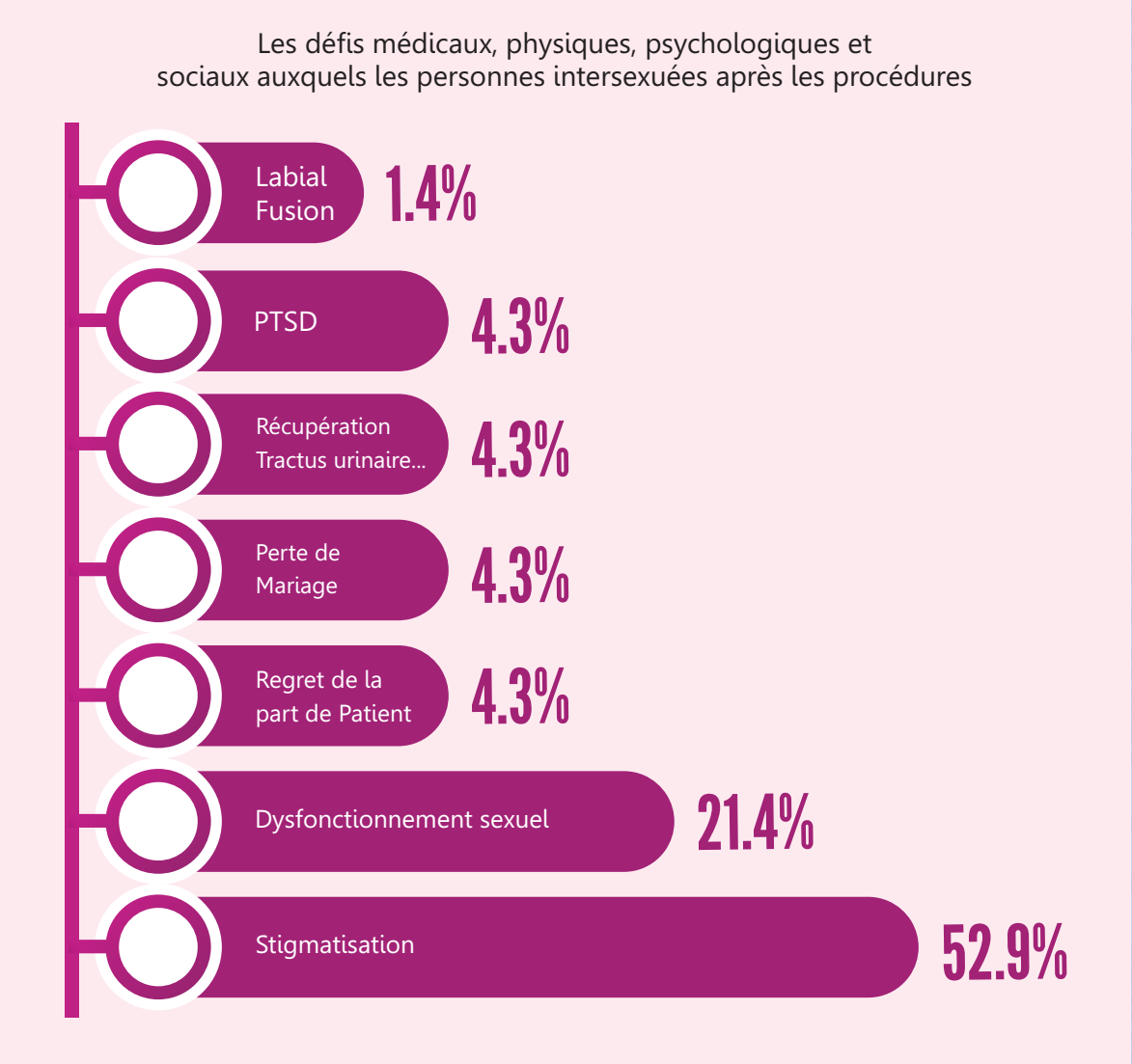


Figure 18: Indique s'il y a eu un suivi après la procédure.

Environ 66 % des personnes interrogées ont fourni des soins de suivi dans la plupart des cas, tandis qu'environ un tiers des patients n'ont pas bénéficié d'un suivi après leur intervention.

4.7. Influences sociétales et culturelles sur les interventions médicales intersexes



La figure 19 montre les difficultés rencontrées par les intersexes après le traitement

Le problème le plus courant auquel sont confrontées les personnes intersexuées après les interventions est la stigmatisation, qui concerne 53 % des cas. Le dysfonctionnement sexuel est également un problème important, signalé par 21 % des personnes interrogées. Parmi les autres difficultés notables figurent la perte du mariage, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et les infections urinaires récurrentes, qui touchent chacune un pourcentage plus faible de personnes. Une grande partie des personnes interrogées n'ont fait état d'aucun problème ou n'ont identifié aucun problème pour diverses raisons.

4.8. Discussion des résultats quantitatifs

La majorité des personnes interrogées estiment avoir un niveau élevé de connaissances sur l'intersexualité, les deux tiers d'entre elles se situant entre 7 et 10 sur une échelle de 1 à 10. Cela montre que la plupart des professionnels de la santé se considèrent bien informés, ce qui est essentiel pour un diagnostic et une prise en charge efficaces de l'intersexualité. Toutefois, plus d'un tiers des répondants évaluent leurs connaissances entre 4 et 6, ce qui indique qu'une proportion importante d'entre eux n'ont qu'une compréhension modérée,

ce qui pourrait affecter la qualité des soins prodigués. La présence d'un petit nombre de personnes qui évaluent leurs connaissances à un niveau très bas souligne la nécessité d'une éducation et d'une formation continues pour garantir que tous les professionnels de la santé sont correctement équipés pour traiter les cas d'intersexualité.

Les naissances d'enfants intersexués sont relativement courantes, la plupart des personnes interrogées ayant vu au moins un cas au cours des cinq dernières années. Cette prévalence souligne l'importance d'avoir des prestataires de soins de santé bien informés et des protocoles standardisés en place. Les méthodes de diagnostic les plus courantes sont l'évaluation clinique et l'anamnèse, ainsi que les études d'imagerie.

D'autres méthodes de diagnostic, telles que les tests hormonaux et les tests génétiques, sont moins utilisées.

Il existe une lacune importante dans la disponibilité de protocoles ou de lignes directrices spécifiques pour le diagnostic de l'intersexualité, de nombreuses personnes interrogées ayant indiqué que leurs hôpitaux ne disposaient pas de telles normes. Cette lacune peut entraîner des incohérences dans les soins et potentiellement aboutir à des diagnostics erronés ou à des interventions inappropriées. La nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre des lignes directrices normalisées est évidente pour garantir un diagnostic uniforme et précis dans tous les établissements de soins de santé.

La majorité des diagnostics sont posés dans la petite enfance, la moitié d'entre eux étant posés dans la tranche d'âge de 0 à 4 ans. Ce diagnostic précoce est essentiel pour intervenir à temps, mais il soulève également des considérations éthiques concernant le consentement et l'impact potentiel des interventions médicales précoces sur des individus trop jeunes pour prendre des décisions éclairées concernant leur corps.

La stigmatisation est le problème le plus courant auquel sont confrontées les personnes intersexuées après les interventions médicales, dans plus de la moitié des cas. Le dysfonctionnement sexuel, la perte du mariage, le syndrome de stress post-traumatique et les infections urinaires récurrentes sont également signalés comme des problèmes importants. Ces résultats montrent l'impact social et psychologique profond de l'intersexualité, en particulier après les interventions médicales.

Le fait que plus d'un quart des patients ne soient pas satisfaits du sexe qui leur a été assigné montre l'importance d'impliquer les personnes intersexuées dans les décisions relatives à leur traitement et la nécessité de mettre en place des pratiques de soins plus favorables et mieux informées.

4.9. Discussion des résultats des entretiens

Les professionnels de la santé qui traitent les personnes intersexuées sont confrontés à des défis importants lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre l'autonomie du patient, la prise de décision éthique et les dilemmes religieux et culturels. Le conflit entre ce qui est médicalement conseillé et ce qui est culturellement acceptable conduit à des questions éthiques complexes, notamment en ce qui concerne l'autonomie, le paternalisme et la justice.

La prise en charge des personnes intersexuées au Nigeria présente des défis importants qui obligent les prestataires de soins à trouver un équilibre entre les considérations éthiques, les sensibilités culturelles et les impératifs médicaux. Bien que certains hôpitaux aient obtenu de bons résultats, beaucoup se heurtent à des obstacles importants, notamment la présentation tardive, la résistance culturelle, le manque d'outils de diagnostic avancés et le coût des soins.

> *L'intersexualité n'est pas une présentation courante en clinique et, probablement parce qu'elle n'est pas encore connue, elle n'est pas encore reconnue. ont été sous-estimés.*

4.9.1. Défis et considérations éthiques liés au traitement des personnes intersexuées.

L'un des principaux défis et considérations éthiques liés au traitement des personnes intersexuées est l'autonomie, c'est-à-dire le droit des patients à prendre des décisions concernant leurs soins médicaux. Les patients intersexués, en particulier les enfants, se voient souvent assigner leur sexe par les soignants. Cette assignation précoce peut compromettre leur autonomie à mesure qu'ils grandissent. Des tensions peuvent apparaître lorsque les préférences des patients entrent en conflit avec les recommandations médicales, ce qui oblige les professionnels de la santé à trouver un équilibre délicat entre le respect de l'autonomie et les conseils médicaux.

> *"Il n'existe pas de principes éthiques clairement établis pour leur gestion au sein de notre hôpital. "Je n'ai pas connaissance d'une politique de l'hôpital.*

En équilibrant l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice, les professionnels de la santé sont confrontés à des défis lorsque les croyances culturelles influencent les décisions médicales. Souvent, ils sont contraints de guider les familles vers des choix médicalement valables, malgré les risques de passer outre les croyances personnelles. Cela montre les difficultés que rencontrent les médecins pour garantir des soins éthiques lorsque les normes sociétales et culturelles entrent en conflit avec les recommandations médicales. La prise en charge des personnes intersexuées au Nigeria présente des défis importants qui obligent les prestataires de soins à trouver un équilibre entre les considérations éthiques, les sensibilités culturelles et les impératifs médicaux. Pour aborder ces questions, il faut adopter une approche prudente, en mettant l'accent sur l'éducation, le soutien et une navigation prudente dans le paysage éthique.

> *La plupart du temps, l'enfant n'est pas au courant des décisions. Ce sont donc les parents qui prennent ces décisions*

> *Nous nous assurons que ce que vous voulez faire correspond à ce qu'ils ont accepté de faire pour vous. les".*

4.9.2. Expériences de l'intersexualité en termes de diagnostic et d'approche thérapeutique au Nigeria

La présentation clinique et les techniques d'imagerie telles que les échographies sont souvent utilisées comme outils de diagnostic de première ligne. Dans certains cas, les dosages hormonaux et l'imagerie sont disponibles, en particulier dans les hôpitaux les mieux équipés. L'indisponibilité de techniques de diagnostic avancées, telles que le caryotypage et les tests génétiques, a constitué une préoccupation majeure, en raison du coût élevé et du manque d'infrastructures dans de nombreux hôpitaux nigérians. Un autre problème important est que de nombreux enfants intersexués naissent à la maison ou se présentent tardivement à l'hôpital, ce qui retarde les diagnostics. Cela entraîne des retards de diagnostic.

Il existe une disparité évidente entre les modalités de diagnostic et de traitement disponibles dans les hôpitaux nigérians et les besoins des patients intersexués. Cette inadéquation a une incidence sur la qualité des soins, car le système manque d'infrastructures et de personnel qualifié dans de nombreux domaines. Le manque de sensibilisation et de compréhension du public à l'égard des maladies intersexes constitue un obstacle important au diagnostic précoce. À cela s'ajoutent des facteurs culturels et religieux qui retardent encore les interventions médicales appropriées.

> *"En général, l'un des problèmes est que certains parents n'ont même pas les moyens de mener l'enquête. Il s'agit alors d'une gestion à long terme. C'est presque quelque chose qui dure toute la vie".*

4.9.3. Impact des croyances culturelles et sociétales dans la gestion et le traitement de l'intersexualité au Nigeria

L'une des croyances qui influencent la prise en charge des personnes intersexuées est la préférence d'un sexe particulier par rapport à un autre. Lorsqu'il existe encore une forte préférence culturelle pour les enfants de sexe masculin, ce préjugé conduit souvent les parents à choisir une identité masculine pour les enfants intersexués, même si les preuves médicales suggèrent le contraire. Cela entraîne des présentations tardives et des complications dans la prise en charge des personnes intersexuées.

Les croyances religieuses influencent également fortement la manière dont les personnes intersexuées sont perçues et prises en charge. Certaines personnes croient que ces conditions sont "la volonté de Dieu" et peuvent s'opposer à une intervention médicale, estimant qu'il s'agit d'une tentative de changer le plan de Dieu. Dans de nombreuses régions du Nigeria, les parents sont souvent trop timides ou honteux pour aborder les questions liées aux organes génitaux de leur enfant, ce qui retarde le diagnostic et le traitement. L'absence de reconnaissance précoce des affections intersexuelles en raison de la stigmatisation sociale entraîne un diagnostic tardif et complique la prise en charge.

"L'une des façons d'aborder le traitement des personnes intersexuées est d'essayer d'éduquer les gens s'ils comprennent. S'ils ne comprennent pas et s'ils ne veulent pas du traitement, il faut les laisser partir"

Les conditions d'intersexualité sont parfois considérées comme un tabou, et les gens peuvent éviter de chercher de l'aide par crainte du jugement de la société. Certains enfants présentant des organes génitaux ambigus peuvent être cachés, voire abandonnés, parce que l'on croit que ces conditions sont liées à la sorcellerie ou à des attaques spirituelles.
Les personnes intersexuées font l'objet d'une stigmatisation sociale importante. Cela conduit souvent à l'isolement des personnes intersexuées, ce qui contribue à des problèmes de santé mentale tels que la dépression, la stigmatisation et le rejet par la société. De nombreux médecins ont souligné l'importance d'éduquer les communautés sur l'existence des conditions intersexes afin de réduire la stigmatisation et d'améliorer les interventions médicales en temps opportun.

4.10. Effets des interventions chirurgicales sur les personnes intersexuées

I. Impacts physiques : De nombreuses personnes intersexuées signalent des difficultés liées à la fonction sexuelle à la suite d'interventions chirurgicales, notamment une perte de sensibilité, des douleurs pendant les rapports sexuels et des difficultés liées à l'excitation sexuelle.

Des infections récurrentes ont également été signalées. Les interventions chirurgicales, en particulier celles qui concernent les voies urinaires ou la reconstruction génitale, peuvent entraîner des infections récurrentes des voies urinaires. Les traitements hormonaux proposés aux patients, qui sont souvent utilisés pour aligner les caractéristiques physiques sur le sexe assigné, peuvent entraîner divers effets secondaires et nécessiter une prise en charge continue. Les risques associés aux interventions chirurgicales comprennent les cicatrices, les douleurs chroniques et les complications nécessitant d'autres opérations.

II. Impacts mentaux: La stigmatisation et le rejet de la société peuvent conduire à une mauvaise image de soi et à une faible estime de soi, ce qui est l'une des expériences vécues par les personnes intersexuées.

De nombreuses personnes subissent un stress psychologique important en raison de la confusion identitaire, l'insatisfaction à l'égard de leur corps et le traumatisme des interventions médicales. Le caractère invasif des premières interventions chirurgicales et le secret qui entoure souvent leur condition peuvent entraîner un syndrome de stress post-traumatique. Les taux élevés de dépression et d'anxiété sont prévalents chez les personnes intersexuées, souvent liés au stress de vivre avec leur condition et au rejet de la société.

III. Impacts sociaux: Les personnes intersexuées sont souvent confrontées à la stigmatisation et à la discrimination dans divers aspects de la vie, notamment à l'école, au travail et au sein de leur communauté.

Dans de nombreuses cultures, l'incapacité à répondre aux attentes traditionnelles en matière de genre et de reproduction peut entraîner des difficultés à nouer des relations matrimoniales. La peur du rejet et des brimades conduit souvent au retrait social et à l'isolement.

Les familles des personnes intersexuées sont souvent confrontées à la détresse et à la pression de la société, ce qui peut affecter la dynamique familiale et les systèmes de soutien.

5.0. Conclusion de l'étude

Les résultats de ces recherches révèlent plusieurs aspects essentiels du diagnostic, des interventions médicales inutiles et des défis permanents auxquels les personnes intersexuées sont confrontées. Le diagnostic précoce, principalement par les parents, et le recours à de multiples méthodes de diagnostic telles que les évaluations cliniques, les tests hormonaux et les échographies sont des tendances communes.

Le traitement implique généralement une thérapie hormonale et une chirurgie, le consentement parental étant la norme, mais cela soulève des inquiétudes quant à l'impact potentiel des interventions médicales précoces sur des personnes qui sont trop jeunes pour prendre des décisions éclairées concernant leur corps, au lieu que ces décisions soient prises en leur nom.

Les personnes intersexuées sont confrontées à des défis importants, notamment la stigmatisation, les dysfonctionnements sexuels et les problèmes psychologiques. La satisfaction à l'égard du sexe assigné et du traitement varie, certains individus exprimant leur insatisfaction en raison de soins inadéquats. L'absence de suivi cohérent aggrave encore ces problèmes, soulignant la nécessité d'améliorer les pratiques de soins de santé et le soutien de la société.

L'absence de protocoles normalisés, combinée aux différents niveaux de connaissances des prestataires de soins, peut conduire à des soins et à des résultats incohérents pour les personnes intersexuées. Il est donc nécessaire d'élaborer des protocoles et des lignes directrices diffusés dans tous les établissements pour le traitement des personnes intersexuées.

Les résultats soulignent également la nécessité d'améliorer l'éducation et la formation des professionnels de la santé, ainsi que la prise de conscience et la sensibilisation aux besoins uniques des personnes intersexuées. En comblant ces lacunes, les personnes intersexuées recevront des soins cohérents, compatissants et informés, ce qui réduira l'impact négatif des interventions médicales et de la stigmatisation sociale sur leur vie.

5.1. Recommandations

i. **Élaboration et mise en œuvre de protocoles normalisés:** Il est urgent d'établir des protocoles et des lignes directrices normalisés pour le diagnostic et la prise en charge des cas d'intersexualité dans tous les établissements de soins de santé. Ces protocoles doivent être fondés sur des données probantes, tenir compte des droits de l'homme et être conçus pour garantir des soins cohérents et précis aux personnes intersexuées. Collaboration avec

les personnes intersexes, les organisations intersexes et les prestataires de soins de santé, Le ministère fédéral de la santé et les parties prenantes locales peuvent contribuer à l'élaboration de ces lignes directrices, en veillant à ce qu'elles soient pertinentes et applicables dans le contexte nigérian.

ii. **Amélioration de la formation et de l'éducation des professionnels de la santé:** Les différents niveaux de connaissance parmi les prestataires de soins de santé indiquent la nécessité de programmes complets d'éducation et de formation axés sur l'intersexualité. Ces programmes devraient couvrir les aspects médicaux, éthiques, psychosociaux et relatifs aux droits de l'homme des soins aux personnes intersexuées, afin de permettre aux professionnels de la santé de fournir des soins informés, empathiques et compétents. Le développement professionnel continu devrait également être encouragé afin de tenir les professionnels de la santé au courant des derniers développements en matière de soins intersexes.

iii. **Approche multidisciplinaire des soins:** La mise en place d'équipes spécialisées, comprenant des pédiatres, des chirurgiens, des psychologues et des conseillers, garantira une prise en charge complète des personnes intersexuées. Cette approche devrait inclure des services de conseil accessibles pour guider les patients et les familles dans la prise de décision, garantissant ainsi un processus de soins plus éthique et plus équilibré.

iv. **Sensibilisation accrue et réduction de la stigmatisation:** des efforts doivent être faits pour sensibiliser à l'intersexualité à la fois dans le système de santé et dans la société en général. Les campagnes d'éducation publique peuvent contribuer à réduire la s tigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes intersexuées, en favorisant un environnement inclusif et favorable. Dans les établissements de soins, des programmes de sensibilisation doivent être mis en œuvre pour lutter contre les préjugés et les idées fausses qui peuvent affecter la qualité des soins prodigués aux patients intersexués.

v. **Participation des personnes intersexuées à la prise de décision :** Il est essentiel d'impliquer les personnes intersexuées, dans la mesure du possible, dans les décisions concernant leurs soins de santé.

Pour les jeunes patients, des efforts doivent être faits pour prendre en compte leur autonomie future et les décisions doivent être prises dans leur meilleur intérêt à long terme.

Cette approche centrée sur le patient doit respecter les droits et la d ignité des personnes intersexuées et garantir que toute intervention médicale est effectuée avec leur consentement éclairé ou celui de leurs tuteurs.

vi. **Soins de suivi et soutien psychologique:** Les systèmes de santé doivent veiller à ce que des soins de suivi soient fournis, y compris des services de soutien psychologique pour aider les personnes intersexuées à faire face aux conséquences sociales et émotionnelles de leur état et de leur traitement. Ce soutien doit être continu et adapté aux besoins

spécifiques des personnes intersexuées tout au long de leur vie.

vii. **Recherche et collecte de données:** Il est nécessaire de mener des recherches plus approfondies et de collecter des données sur l'intersexualité au Nigeria. Cela permettra de mieux comprendre la prévalence, les résultats et les défis auxquels sont confrontées les personnes intersexuées. Ces données sont essentielles à l'élaboration de politiques éclairées et à l'amélioration des pratiques de soins de santé liées à l'intersexualité. Des partenariats avec des établissements universitaires, des organisations de soins de santé et des groupes de défense des personnes intersexuées peuvent contribuer à orienter les efforts de recherche et à faire en sorte qu'ils soient inclusifs et représentatifs.

viii. **viii. Défense des politiques et protections juridiques:** Des politiques devraient être élaborées pour protéger les personnes intersexuées contre les pratiques néfastes et la discrimination et pour garantir leur accès à des soins de santé appropriés. Des cadres juridiques devraient également être mis en place pour protéger les droits des enfants intersexués, notamment en ce qui concerne le consentement aux traitements médicaux.

Références

Résolution de la commission africaine sur les droits des personnes intersexuées en afrique (2023), ce qu'elle signifie pour les acteurs étatiques et non étatiques en afrique : Un guide de la résolution 552 sur la promotion et la protection des droits des personnes intersexuées en Afrique. pg 1.
https://www.chr.up.ac.za/images/researchunits/sogie/documents/Resolution_552_booklet_fin al-2.pdf

Amadiume, Ifi (1987). Filles masculines, maris féminins : Genre et sexe dans une société africaine. Zed Books.

Aniekwu, Nkoli. (2006). La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et l'état de la mise en œuvre du droit aux soins de santé au Nigeria.

Anne Tamar-Mattis, Arlene Baratz, Katharine Baratz Dalke & Katrina Karkazis , Psychologie & Sexualité (2013) : Emotionally and cognitively informed consent for clinical care for differences of sex development, Psychology & Sexuality, DOI : 10.1080/19419899.2013.831215.

Anne Tamar-Mattis, Arlene Baratz, Katharine Baratz Dalke & Katrina Karkazis , Psychology & Sexuality (2013): Emotionally and cognitively informed consent for clinical care for differences of sex development, Psychology & Sexuality, DOI:10.1080/19419899.2013.831215

Berry AW, Monro S. Ageing in obscurity : a critical literature review regarding older intersex people. Sex Reprod Health Matters. 2022 Dec;30(1):2136027. doi : 10.1080/26410397.2022.2136027. PMID : 36369786 ; PMCID : PMC9704076.

Carpenter M. The human rights of intersex people: addressing harmful practices and rhetoric of change. Reprod Health Matters. 2016 May;24(47):74-84. doi: 10.1016/j.rhm.2016.06.003. Epub 2016 Jul 12. PMID: 27578341.

Creighton, S. M., Michala, L., Mushtaq, I. et Yaron, M. (2013). Childhood surgery for ambiguous genitalia : glimpses of practice changes or more of the same ? Psychology & Sexuality, 5(1), 34-43. https://doi.org/10.1080/19419899.2013.831214

Creighton SM, Minto CL, Steele SJ. Objective cosmetic and anatomical outcomes at adolescence of feminising surgery for ambiguous genitalia done in childhood. Lancet. 2001Jul 14;358(9276):124-5. doi: 10.1016/S0140-6736(01)05343-0. PMID: 11463417.

Davis R, Campbell R, Hildon Z, Hobbs L, Michie S. Theories of behaviour and behaviour change across the social and behavioural sciences : a scoping review. Health Psychol Rev. 2015;9(3):323-44. doi : 10.1080/17437199.2014.941722. Epub 2014 Aug 8. PMID : 25104107 ; PMCID : PMC4566873.

Dreger, A. D. (1998). "Le sexe ambigu ou la médecine ambivalente : questions éthiques dans le traitement du cancer du sein. de l'intersexualité. Intersexualité. Hastings Center Report, 28(3), 24-35 https://doi.org/10.2307/3528648
Esteban C, Ortiz-Rodz DI, Muñiz-Pérez YI, Ramírez-Vega L, Jiménez-Ricaurte C, Mattei-Torres E, Finkel-Aguilar V. Quality of Life and Psychosocial Well-Being among Intersex-Identifying Individuals in Puerto Rico : An Exploratory Study. Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb 7;20(4):2899. doi : 10.3390/ijerph20042899. PMID : 36833596 ; PMCID : PMC9957316.

Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body : Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York : Basic Books

Garland, Jameson & Slokenberga, Santa. (2018). Protéger les droits des enfants intersexués contre les interventions médicales de conformation de genre non consensuelles: The View from Europe. Medical Law Review. 27. 10.1093/medlaw/fwy039.

Holmes M 2011, The Intersex Enchiridion : Naming and Knowledge Somatechnics, septembre 2011, vo. 1, n° 2 : pp. 388-411

Karkazis, Katrina. (2008). Fixing Sex : Intersexe, Medical Authority, and Lived Experience (Intersexe, autorité médicale et expérience vécue). 10.1515/9780822389217.

Liao LM, Wood D, Creighton SM. Parental choice on normalising cosmetic genital surgery (choix parental sur la normalisation de la chirurgie génitale esthétique). BMJ. 2015 Sep 28;351:h5124. doi : 10.1136/bmj.h5124. PMID : 26416098.

Njambi, Wairimu. (2009). ONE VAGINA TO GO". Australian Feminist Studies - AUST FEMINIST STUD. 24. 167-180. 10.1080/08164640902852381.

Oyěwùmí, O. (1997). L'invention des femmes : Making an African Sense of Western Gender Discourses (NED-Nouvelle édition). University of Minnesota Press. http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttt0vh

Reis, H. T. (2007). Steps toward the ripening of relationship science. Personal Relationships, 14(1), 1-23. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2006.00139.x

https://www.vanguardngr.com/2021/04/kano-govt-sponsors-surgery-of-7-patients-with-inters ex-problem/

Liste des graphiques et tableaux

La figure 1. Montre la tranche d'âge des personnes interrogées.

La figure 2. Indique le nombre d'établissements dans chaque zone des personnes interrogées.

Figure 3: Indique la désignation et la spécialité de toutes les personnes interrogées.

Figure 4: Montre le nombre d'années de pratique des personnes interrogées

Figure 5: Montre l'échelle des connaissances des personnes interrogées sur l'intersexualité

La figure 6: montre les cas d'intersexualité observés au cours des 5 dernières années par les personnes interrogées.

La figure 7: présente les critères diagnostiques et les méthodes utilisées pour identifier l'intersexualité.

Figure 8: Indique si des protocoles ou des lignes directrices spécifiques sont suivis pour le diagnostic de l'intersexualité.

Figure 9: Montre le diagnostic des cas vus par les personnes interrogées.

Figure 10: Indique le diagnostic le plus récent consulté par la personne interrogée

Figure 11: Montre l'âge du patient lorsque le diagnostic récent a été posé.

Figure 12 : Montre les réponses de la personne qui a identifié le cas.

La figure 13: Montre la méthode utilisée pour le diagnostic du cas le plus récent.

Figure 14: Montre le traitement proposé par les professionnels pour le cas le plus récent.

Figure 15: Montre l'âge de l'intersexe au moment du traitement.

Figure 16: Indique qui a donné son accord pour le traitement.

Figure 17: Indique si le patient a changé d'environnement après la procédure.

Figure 18: Indique s'il y a eu un suivi après le traitement.

La figure 19: Montre les difficultés rencontrées par les intersexes après le traitement.

Tableau 1: Définition des termes

Tableau 2: Nombre de répondants par État et par zone

Tableau 3: Nom de l'établissement et nombre de répondants

Appendices

Table 1: Definition of terms

Terms	Definition
Intersex Genital Mutilation (IGM)	A Medical or surgical intervention performed on intersex individuals, to alter their genitalia to conform to binary sex norms. These procedures can have lifelong physical and psychological consequences.
Androgen Insensitivity Syndrome (AIS)	A condition in which a person who is genetically male (XY chromosomes) is resistant to male hormones (androgens). As a result, they may have female physical traits despite having male genetic makeup.
Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH)	A group of genetic disorders affecting the adrenal glands, leading to an overproduction of androgens. It can result in ambiguous genitalia in newborn females and early puberty in both sexes.
Klinefelter Syndrome	A genetic condition affecting males, where an extra X chromosome (XXY instead of XY) causes physical, developmental, and reproductive issues, including reduced testosterone production and infertility.
Turner Syndrome	A chromosomal disorder in females where part or all of one of the X chromosomes is missing. It can lead to short stature, ovarian dysfunction, and other health issues.
Gonadal Dysgenesis	A condition in which the gonads (ovaries or testes) do not develop properly, leading to impaired sexual development and often resulting in infertility.
Ovotestis	A rare condition where an individual has both ovarian and testicular tissue in the same or opposite gonads, leading to ambiguous genitalia and mixed sexual characteristics.
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome	A disorder affecting females, characterized by the underdevelopment or absence of the uterus and upper part of the vagina, despite having normal external genitalia and ovarian function.
5 Alpha Reductase Deficiency	A rare genetic condition in which a male is born with external genitalia that may appear female or ambiguous due to a deficiency in the enzyme 5-alpha reductase, which is crucial for male sexual development.
Disorder of Sexual Development (DSD)	A group of congenital conditions where the development of chromosomal, gonadal, or anatomical sex is atypical, leading to ambiguous genitalia or differences in sexual development.
Clitoromegaly	An abnormal enlargement of the clitoris, which can occur as a result of congenital conditions like CAH or due to hormonal imbalances.
Labia Fusion	A condition where the labia minora or majora fuse together, often due to congenital factors or hormonal imbalances, leading to complications with urination and sexual function.
Clinical Assessment and History	A fundamental part of the diagnostic process, involving a thorough physical examination and review of the patient's medical history to identify signs and symptoms of a condition.
Endoscopic Evaluation	A minimally invasive procedure using an endoscope (a flexible tube with a light and camera) to examine internal organs and structures, such as the gastrointestinal tract or reproductive organs.
Gonadal Biopsy	A surgical procedure where a small sample of tissue is taken from the gonads (ovaries or testes) for examination under a microscope to diagnose or assess reproductive health.
Abdominopelvic Ultrasound	A non-invasive imaging technique that uses sound waves to create images of the organs within the abdomen and pelvis, often used to assess the reproductive organs.
Imaging Studies	Refers to various techniques (e.g., ultrasound, MRI, CT scans) used to create images of the body's internal structures to diagnose or monitor medical conditions.
Genetic Testing	Laboratory analysis of DNA to identify genetic disorders or conditions, often used to diagnose syndromes like AIS, CAH, or Turner Syndrome.

Test harmonieux	Les tests sanguins qui mesurent les niveaux d'hormonesafin de diagnostiquer ou de surveiller les anomalies liées à la fonction endocrine, y compris lesmaladies intersexuelles.
Laparosco py	Procédure chirurgicale mini-invasive dans laquelle une caméra est insérée dans l'abdomen par de petites incisions afin d'examiner les organeset d'effectuer des interventions chirurgicales.
Caryotypage	Procédure de laboratoirequi examine la taille, la forme et le nombre de chromosomes dans les cellules, utilisée pour diagnostiquer des maladies génétiques telles que le syndrome de Kinefelter ou le syndrome de Tu rner.
Imagerie par résonance magnétique (IRM)	Technique d'imagerie non invasive qui utilise des champs magnétiqueset des ondes radio pour créer des images détaillées des organes et des tissus du corps, souvent utiliséespour diagnostiquer des affections complexes.
In vestigation labo ratoire	Généralités{erm pour diverses{essais{conduits{en{laboratoire{(ex. :analysesde sang, analyses d'urine) Io diagnostiquer ou surveiller les conditions de santé.
Traitement hormonal	L'utilisation de l'hormonothérapie pour traiter les affections liées à des déséquilibres ou à des déficits en hormones, comme la thérapie de remplacement de l'hormone pour l'HCA ou l'AIS.
Chirurgie reconstructive du pelvis	Procédures chirurgicales visant à corriger ou à reconstruire les organes pelviens, souvent utilisées en cas d'anomalies congénitales ou après un traumatisme.
Ectomie des gonades	L'ablation chirurgicale desgonades (testicules ou ovaires), parfois pratiquée dans les cas de condit ions intersexes pour réduire le risque de cancer ou dans le cadre d'une chirurgie de confirmation du sexe.
Dysfu n ct ion sexuelle	Difficulté ou incapacité à éprouver une fonction sexuelle normale, pouvant résulter de conditionsphysiques, psychologiquesou médicales, y compris celles liées à la co nd it ion intersexe.
Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT)	Un état de santé mentale déclenché par un événement traumatique, qui peut affecter des personnes ayant subi des procédures médicales invasives ou ayant été victimes de stigmates.

Tableau 2 : Nombre de répondants par État et par zone

Région	État	Nombre de répondants
Nord-Est	Bauchi	3
	Gombe	2
	Adamawa	2
	Yobe	2
	Borno	2
	Taraba	3
Total Nord-Est		14
Nord-Ouest	Kebbi	2
	Sokoto	2
	Jigawa	2
	Kano	6
	Kaduna	2
	Katsina	2
	Zamfara	2
Total Nord-Ouest		18
Centre-Nord	Plateau	2
	Niger	2
	Kogi	3
	FCT	4
	Kwara	2
	Benue	2
	Nasarawa	2
Total Centre-Nord		17
Sud-Est	Imo	2
	Ebonyi	1
	Anambra	3
	Enugu	1
	Abia	2
Total Sud-Est		9
Sud-Ouest	Oyo	2
	Osun	2
	Ondo	2
	Ekiti	2
	Ogun	3
	Lagos	6
Total Sud-Ouest		17

Table 2: Number of respondents per state and Zone

Région	État	Nombre de répondants
Sud-Sud	Bayelsa	2
	Cross River	4
	Delta	2
	Rivers	3
	Akwa Ibom	2
	Edo	2
Total Sud-Sud		15

Tableau 3 : Nom de l'établissement et nombre de répondants

Nom de I'hopital	Nombre de répondants
Hôpital universitaire Ahmadu Bello de Zaria	2
Hôpital universitaire fédéral Alex Ekwueme Abakaliki	1
ALEX EKWUEME FEDERAL TEACHINGS HOSPITAL ABAKALIKI (AEFTHA)	
Hôpital universitaire Aminu Kano	4
ATBUTH, Bauchi	2
Hôpital universitaire de l'État de Benue Makurdi	2
Hôpital spécialisé Dalhatu Araf	2
Hôpital universitaire de l'État du Delta, Oghara	2
Centre médical fédéral Abeokuta Centre	3
médical fédéral Azare Centre médical	2
fédéral Birnin-Kebbi Centre médical fédéral	1
Jalingo Centre médical fédéral Umuahia	3
Centre médical fédéral, Jabi Centre	2
médical fédéral Abuja, Nguru Centre	1
médical fédéral Birnin-Kebbi	2
Centre médical fédéral d'Owo État d'Ondo Centre	1
médical fédéral de Yenagoa Centre médical	2
fédéral de Bida	1
Centre médical fédéral, Bida Centre	2
médical fédéral, Gusau Hôpital universitaire	
fédéral Ido-Ekiti Hôpital universitaire fédéral	1
Lokoja Hôpital universitaire fédéral,	1
Gombe	2
HÔPITAL UNIVERSITAIRE FÉDÉRAL, OWERRI	2
Hôpital universitaire fédéral, Owerri, État d'Imo	1
FTH KATRINA	2
Hôpital spécialisé d'Irrua	1
Hôpital universitaire de Jos	1
Hôpital spécialisé de l'État de Kogi Lokoja	2
Lagos University Teaching Hospital Idi Araba Lagos LASUTH	
(Lagos STATE University Teaching Hospital) MAUTH YOLA	2
Hôpital national	2
Hôpital orthopédique national de Kano	5
Hôpital universitaire Nnamdi Azikiwe Nnewi Anambra stale Rasheed shekoni	1
Hôpital universitaire fédéral dutse SpecialiH Hospital Sokoto	2
Hôpital universitaire de l'Université d'Abuja	1
UDUTH	1
Hôpital universitaire Uniosun, Osogbo, État d'Osun UNIVERSITY	
COLLEGE HOSPITAL, IBADAN	
Hôpital universitaire de l'Université du Bénin Hôpital	2
universitaire de l'Université de Calabar Hôpital	1
universitaire de l'Université de Calabar Hôpital	1
universitaire de l'Université d'Ilorin	1
Hôpital universitaire de l'Université de Maiduguri Hôpital	2
universitaire de l'Université du Nigeria Hôpital	
universitaire de l'Université de Port Harcourt	1
Hôpital universitaire de l'Université d'Uyo. État d'Akwa Iborn	3
	1
	2
	2

Ce Document a Été Élaboré et Publié Par Intersex Nigeria

Website: intersexnigeria.org
Email: info@intersexnigeria.org